

Diseño de un sistema de autoevaluación para clubes deportivos sobre factores de riesgo que atentan contra la salvaguarda de la infancia y adolescencia.

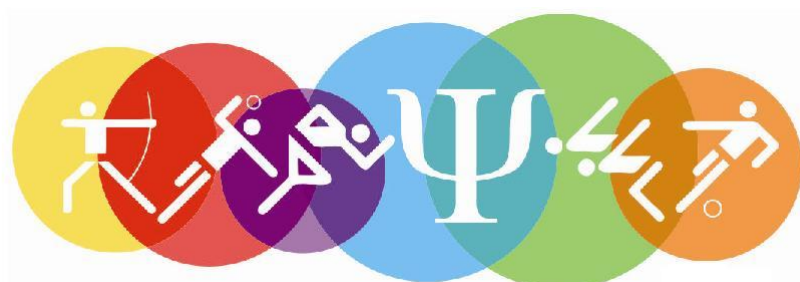
Estudio piloto.

Autora: Teresa González González,

Tutor: Víctor J. Rubio Franco

Curso 2023 – 2024

Máster en Psicología de la Actividad Física y del Deporte.



Agradecimientos

Quiero aprovechar este espacio para agradecer a las personas que me han acompañado en este camino. Cada vez soy más conscientes como las unas nos necesitamos a las otras y me siento afortunada de contar con apoyos fundamentales en mi vida.

A todas las y los profesionales que han contribuido para que la psicología del deporte y la actividad física sea una disciplina que puede construir un mundo mejor.

Al equipo de investigación, por abrirme un nuevo mundo, ofrecerme oportunidades y apostar verdaderamente por esta temática.

Por último, gracias a los niños, niñas y adolescentes, por encontrar en ellas y ellos el sentido en la realización de este trabajo.

Resumen

La Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la violencia (LOPIVI) promueve una legislación que sirve de marco y referencia para la salvaguarda en el deporte. Se pretende que el deporte verdaderamente sea seguro, saludable, inclusivo y divertido; fomentando la integridad, el disfrute y el mantenimiento de la práctica deportiva. En el presente trabajo se diseña CHASSE, un sistema de autoevaluación para clubes deportivos sobre factores de riesgo que atentan contra la salvaguarda. Participan de este estudio piloto, en el nivel organizacional, tres clubes deportivos de diferente tamaño de la Comunidad de Madrid. Se analiza la fiabilidad, siendo significativo ($p < 0.05$) el acuerdo interjueces en todos los casos. Los resultados indican que el Club 1 presenta un riesgo bajo, el Club 2 un riesgo alto y Club 3 un riesgo moderado, que puede atentar contra la salvaguarda para la infancia y adolescencia deportista. Se considera fundamental plantear líneas futuras de investigación y continuar dando pasos en esta materia.

Palabras clave: LOPIVI, Prevención, Riesgo, Clubes Deportivos

Abstract

The Law on Comprehensive Protection of Children and Adolescents against Violence (LOPIVI) promotes legislation that serves as a framework and reference for safeguarding in sport. It is intended that sport truly be safe, healthy, inclusive and fun; promoting integrity, enjoyment and maintenance of sports practice. In this work, CHASSE is designed, a tool that allows sports clubs to self-evaluate. Three sports clubs of different sizes from the Community of Madrid participate in this pilot study, at the organizational level. The interjudge agreement between the evaluators of each club is analyzed and is significant ($p\text{-value} < 0.05$). The results indicate that the first club satisfactorily complies with most of the blocks, the second obtains alarming results and may be a high-risk club, and the third club is at the limit of danger for childhood and adolescent athletes. It is considered essential to propose future lines of research and continue taking steps in this matter.

Key words: LOPIVI, Prevention, Risk, Sports Clubs

Índice de tabla

Resumen.....	3
1. Introducción	7
2.Marco teórico	8
2.1. Beneficios de la práctica deportiva para la infancia y adolescencia	8
2.2. Amenazas de la práctica deportiva para la infancia y adolescencia	10
2.2.1.Lesiones deportivas.....	10
Relevancia	10
Factores de riesgo	11
2.2.2. TCA.....	12
Relevancia	12
Factores de riesgo	13
2.2.3. Burnout.....	13
Relevancia	13
Factores de riesgo	14
2.2.4. Consumo de sustancias nocivas	15
Relevancia	15
Factores de riesgo	16
2.2.5. Agresividad y violencia	16
Relevancia	16
Factores de riesgo	17
2.2.6. Ausencia de salvaguarda	18
2.3. Políticas de salvaguarda en el deporte para la infancia y adolescencia.....	19
2.3.1. LOPIVI en el ámbito deportivo.....	19
3.Desafíos en la aplicación de la salvaguarda en el deporte.....	22
4.Metodología	23

4.1. Objetivo	23
4.2. Procedimiento	23
4.2.1.Diseño del instrumento.....	23
A. Niveles	24
B.Bloques.....	24
C. Variables	25
4.2.2.Instrucciones	27
4.3. Participantes.....	27
5.Resultados	29
6.Discusión	32
7.Conclusiones	34
8.Limitaciones y líneas futuras de trabajo e investigación	35
9.Referencias	37
<u>10.Anexos</u>.....	50
Anexo 1. Obligaciones de las entidades deportivas LOPIVI.	50
Anexo 2. Convención de los derechos del Niño	52
Anexo 3. Hoja de información y consentimiento Subcomité de Ética.....	53
Anexo 4. Leyenda de Condiciones y sus factores de riesgo asociados	57
Anexo 5. Relación entre ítems CHASSE-Organizacional, condición y factores de riesgo.....	60
Anexo 6. Relación entre ítems CHASSE-Equipo, condición y factores de riesgo.	65
Anexo 7. Instrucciones generales CHASSE.....	71
Anexo 8. Instrucciones específicas CHASSE-Organizacional	73
Anexo 9. Instrucciones específicas CHASSE-Equipo	75

Índice de tablas

<i>Tabla 1.</i> Fundamentos bibliográficos de CHASSE	24
<i>Tabla 2.</i> Respuestas obtenidas en el estudio piloto	26
<i>Tabla 3.</i> Principales resultados de CHASSE-Organizacional.....	28
<i>Tabla 4.</i> Resultados fiabilidad- nivel organizacional.....	30

Introducción

El deporte tiene múltiples beneficios para la infancia y adolescencia (UNICEF, 2019). Pero también muestra su cara oscura, como lo revelan los alarmantes casos de abusos físicos, emocionales o sexuales, y otras formas de violencia con prevalencia recurrente y en ocasiones normalizada (Hartill et al, 2021). Existen condiciones que atentan contra la integridad, el disfrute y el mantenimiento de la práctica deportiva. Las principales circunstancias detectadas son las lesiones deportivas (Beranek et al. 2021), los trastornos de conducta alimenticia (Aumaitre et al, 2021), el burnout temprano (Martínez de Quel et al; 2019) el consumo de sustancias nocivas (Roldan et al, 2019), la agresividad (Hartill et al, 2021) y la falta de políticas de salvaguarda (Kerr y Stirling, 2012). Cabe pensar, por tanto, que el deporte no es del todo seguro, saludable, inclusivo y divertido para la infancia y adolescencia.

La LOPIVI plantea un nuevo paradigma de protección integral de forma holística, además, amplía el concepto de violencia desde la acción hasta la omisión y trato negligente. Se establecen una serie de obligaciones y recomendaciones como la designación de una persona al rol de delegado de protección, la cual por sí sola resulta insuficiente. Para la aplicación real de medidas de salvaguarda existen, por lo menos, dos grandes dificultades: la cultura del deporte orientada al resultado y la competición, y la ausencia de herramientas accesibles para los clubes que les sirva como diagnóstico.

El presente estudio piloto, del diseño de CHASSE, pretende dotar a los clubes deportivos de una herramienta fácilmente administrable que les ayude a construir clubes más seguros, saludables, divertidos e inclusivos, cumpliendo además con la LOPIVI. Gracias a CHASSE podrán autoevaluarse y poseer un diagnóstico de su situación y su nivel de riesgo para diferentes condiciones relativas a la salvaguarda.

2. Marco teórico

2.1. Beneficios de la práctica deportiva para la infancia y adolescencia

El deporte puede resultar para la infancia y adolescencia una experiencia educativa, socializadora y lúdica positiva, donde adquirir valores fundamentales para su desarrollo vital. Asimismo, dotarles de beneficios para su salud física y mental, producir mejoras en el aprendizaje académico e incrementos en los niveles de confianza y autoestima (UNICEF 2004; 2019). La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que los niños y adolescentes de entre 5 y 17 años realicen al menos 60 minutos de actividad física moderada a vigorosa diariamente para optimizar sus múltiples beneficios: físicos, psicológicos y sociales.

Según el estudio de Janssen y LeBlanc (2010), la actividad física regular mejora la salud cardiovascular, aumenta la fuerza y la resistencia muscular, y favorece el desarrollo óseo, reduciendo el riesgo de osteoporosis en etapas posteriores de la vida. Además, la actividad física está asociada con un menor riesgo de obesidad infantil, lo cual es crucial dada la creciente prevalencia de este problema de salud pública.

El deporte y la actividad física también tienen un impacto positivo en la salud psicológica. Estudios han demostrado que la actividad física regular está asociada con una mejoría en los estados de ánimo y una disminución de los síntomas de depresión y ansiedad en menores (Biddle & Asare, 2011). Además, la práctica deportiva puede aumentar la autoestima y la autoeficacia, proporcionando una mayor sensación de logro y competencia. Este fortalecimiento psicológico resulta vital durante los años de formación, ya que establece una base sólida para la resiliencia y el bienestar emocional a lo largo de la vida.

La participación en deportes y actividades físicas también ofrece importantes beneficios sociales. Según Bailey (2006), el deporte puede ser un poderoso medio para el desarrollo de habilidades sociales, como la cooperación, la empatía y la resolución de conflictos. A través de la participación en actividades deportivas, los niños aprenden a trabajar en equipo, a respetar las reglas y a interactuar de manera constructiva con sus pares, lo cual puede mejorar sus habilidades de comunicación y establecer relaciones positivas. Además, el deporte puede proporcionar un sentido de pertenencia y comunidad, contribuyendo a una mayor integración social y disminuyendo el riesgo de conductas antisociales y aislamiento social. (UNICEF, 2004)

De hecho, en contextos vulnerables se emplea el Deporte para el Desarrollo y la Paz (DDP) como estrategia de intervención social. Esta concepción del deporte, a diferencia del deporte tradicional, no se orienta hacia los resultados, sino que pone el objetivo en el proceso y el impacto social (UNICEF, 2019). El deporte, por tanto, puede ser un entorno seguro (UNICEF, 2019), puede mejorar la salud; ser saludable (Fernández, 2003) (Janssen y LeBlanc, 2010) (Biddle & Asare, 2011), generar grandes oportunidades de participación e integración; ser inclusivo (UNICEF, 2019) (Bailey, 2006), y cumplir con los principales motivos por los que la infancia y adolescencia practica deporte; ser divertido. (Azofeifa, 2006).

Sin embargo, algunas investigaciones han demostrado que la participación infanto-juvenil en deportes produce resultados tanto positivos como negativos; desencadenando al igual que beneficios también problemas físicos y psicosociales (Bean et al, 2018).

2.2. Amenazas de la práctica deportiva para la infancia y adolescencia

La cara oscura del deporte infanto-juvenil es fácilmente visible con casos mediáticos de abuso sexual, como por ejemplo los casos de Miguel Millán en el atletismo o Torres Baena en el kárate. Sin embargo, la violencia sexual resulta ser la forma menos recurrente de violencia en el deporte y fuera del mismo (Hartill, 2021). Mientras tanto existen circunstancias, incluso normalizadas, que están afectando a la integridad, disfrute y mantenimiento de la práctica deportiva (Berengüi, 2018).

El deporte tradicional o competitivo puede fomentar implícitamente una cultura de valores negativos; como la violencia, las relaciones de poder, la discriminación o la desigualdad (Hernández, 2017). Tres de cada cuatro encuestados de una muestra de seis países europeos notificaron haber padecido algún tipo de violencia interpersonal en su experiencia deportiva durante su etapa de formación (Hartill et al, 2021)

La infancia y adolescencia deportista es un colectivo vulnerable a la violencia en su concepto amplio (UNICEF, 2019) (LOPIVI). Existen circunstancias propias del ámbito deportivo (lesiones deportivas, TCA, burnout, consumo de sustancias nocivas, agresividad y violencia, y falta de salvaguarda) con datos alarmantes. A continuación, se detallan tales circunstancias; indicando su relevancia en este colectivo y sus factores de riesgo asociados.

2.2.1. Lesiones deportivas

Relevancia

Las lesiones deportivas son ampliamente estudiadas y en varios casos llevan el abandono de la práctica deportiva. Se consideran un problema de salud importante especialmente entre la infancia y adolescencia (Beranek et al. 2021). Algunos autores identifican que el riesgo de lesiones aumenta entre los 6 y 12 años debido a la participación en juegos y actividades más complejas que requieren mayor dinamismo.

No obstante, Martínez de Quel et al (2019) observó una mayor incidencia lesional a los 13 años. Normalmente los jóvenes de esta franja de edad en nuestra sociedad se inician en clubes deportivos (Caracuel et al, 2023). La prevalencia de lesiones en términos colectivos se encuentra desde 5.0 hasta 34.4 lesiones cada 1000 horas de práctica (Caine et al, 2008) En el estudio de Prieto-González (2021) se investiga la prevalencia en España entre los 14 y 21 años, obteniendo un promedio de 2.64, subiendo para el fútbol a 7.21 cada 1000 horas de práctica. Entre las lesiones más graves resulta relevante destacar las del ligamento cruzado anterior (LCA) de rodilla (Hallén et al, 2024). En el estudio longitudinal de prevalencia en Australia de Shaw y Finch (2017) se encuentra un incremento de la lesión de 2,74 a 6,79 por 100.000 habitantes comparando la temporada 2005/2006 con la 2014/2015.

Factores de riesgo

Von Rosen, et al. (2017) presenta uno de los mayores estudios de cohorte prospectivo sobre factores de riesgo en deportistas de élite adolescentes desde una perspectiva holística. Se demuestra que aumentar las cargas, la intensidad y disminuir el descanso correlaciona con un mayor riesgo de lesión en comparación con ningún cambio en estas variables. Además, se ha estudiado la relación con una autoestima basada en el rendimiento y resultados competitivos, encontrando también resultados significativos en la aparición de lesiones. Asimismo, resulta significativo el trabajo específico de las capacidades físicas. (von Rosen, et al. 2017). Por otro lado, resulta relevante el trabajo de Frisch (et al 2009) con atletas y jugadores de educación secundaria, aportando como factor relevante las lesiones previas, que conllevan un alto porcentaje de recaídas. En este sentido contar con un plan de entrenamiento y de rehabilitación adaptado es fundamental. Se ha encontrado una disminución de lesiones en deportistas que han participado de programas de prevención basados en ejercicios

(Rössler et al,2014) (Aaltonen et al,2007). Pero no solo una prevención desde el ejercicio es necesaria, pues una alimentación adecuada es un pilar esencial, formando parte del entrenamiento invisible que optimiza el rendimiento y la recuperación. Aquellos deportistas que cuenten un índice de nutrición menor o igual a 4 (correspondiente a un estado de desnutrición) multiplican su riesgo de sufrir lesiones. (Jeukendrup A, 2010). También se ha estudiado que padecer episodios de ansiedad y estrés pueden incrementar la susceptibilidad de lesiones durante la actividad física. (Gledhill, A, 2018). Por último, resulta relevante identificar que la práctica deportiva se desarrolle empleando los equipos de protección necesarios adecuadamente dotados, en espacios físicos y condiciones climáticas seguras.

Para concluir, se ha expuesto como existen factores intrínsecos relevantes: las lesiones previas, la condición física (flexibilidad, fuerza, estabilidad, equilibrio, coordinación...), el estrés, habilidades de afrontamiento, ansiedad competitiva, personalidad y el propio comportamiento del atleta. Sin olvidar otros factores externos: características del deporte, entrenamiento y periodización, entorno deportivo y comportamiento de los oponentes. Se considera fundamental para la prevención considerar todos estos factores, asimismo, centrarse en varios y no solo uno reducirá considerablemente el riesgo de lesión (von Rosen, et al.,2017)

2.2.2. TCA

Relevancia

Después de la pandemia se triplicaron los trastornos mentales en la infancia y adolescencia (Aumaitre, et al., 2021), entre ellos, los trastornos de la conducta alimentaria (TCA). En nuestra sociedad se valora positivamente estar “en buen estado de forma” y en ocasiones el deporte se convierte en un medio para lograr este ideal de belleza, en especial durante la adolescencia (Fernández et al, 2010). Los trastornos más

frecuentes son la Anorexia Nerviosa y la Bulimia Nerviosa (Duran et al, 2021). Sin embargo, también existen trastornos subclínicos latentes en el ámbito deportivo. Estos son la anorexia por actividad, el corredor obligatorio y la vigorexia, los cuales presentan características comunes como son la disminución de ingesta alimentaria o dietas, el ejercicio excesivo-obsesivo y la autoexigencia. (Berengüi. 2018.)

Factores de riesgo

Berengüi (2018) clasifica los desencadenantes en tres causas: sociales, personales y propias del deporte. Entre las causas sociales, se engloba la presión o valoración excesiva a la estética, delgadez y triunfo, un estilo autoritario del entrenador o la existencia de un beneficio económico, etc. En cuanto a características personales, se encuentra el alto grado de perfeccionismo, la creencia de que la delgadez mejora el rendimiento, la baja autoestima y que la estima dependa del reconocimiento de éxitos. Por último, el tipo de deporte por sí mismo es relevante, siendo más vulnerables los estéticos, los que se clasifican por categoría de peso, los de gimnasio y resistencia. Para cualquiera de ellos se debe considerar el nivel de práctica, exigencia o profesionalización y la categoría en la que se compite. Se puede resumir que la prevalencia de TCA es mayor en atletas de mayor nivel competitivo y que sufren mayor presión (Orlando, 2023), en los que siguen dietas (Walter et al, 2022), en deportes dependientes del peso o de categorías (Díaz & Díaz.,2012) y en el género femenino (Fernández & Pedrón.,2022).

2.2.3. Burnout

Relevancia

El síndrome de burnout proviene del ámbito laboral por ello los primeros estudios en el deporte se realizaron con deportistas olímpicos, donde existe mayor profesionalización, durante los años 80 (Carlin et al 2010). Sin embargo, son múltiples

los autores que afirman de la existencia de burnout en población infanto-juvenil. (García et al., 2016). Este fenómeno ocurre tanto en el ámbito académico como deportivo, impulsado por intensas presiones y altas expectativas externas (Cohn, 1990) Siguiendo el marco teórico de Maslach y Jackson (1981), se plantea un modelo tridimensional del síndrome que mantiene una experiencia duradera de agotamiento físico y emocional, una reducida realización y una devaluación personal. Feigley (1984) incluso hace referencia a su aparición en algunos casos a los 10 años de edad. En estos momentos del desarrollo muchos niños no pueden gestionar las cargas de estrés que el contexto deportivo les proporciona y en varias ocasiones desencadena en abandono prematuro del deporte. (Garcés de Los Fayos, 1993). Las consecuencias son variadas; desde problemas físicos (enfermedades y lesiones), insatisfacción con el rol deportivo, expectativas incumplidas, disminución de la diversión, problemas de concentración, sensaciones negativas y sentimientos de aislamiento (Berengüi, 2018).

Factores de riesgo

La propia naturaleza y características del deporte, usualmente requieren de una orientación al logro y excesiva dedicación, que pueden predisponer al burnout. (Carlin, 2010). A nivel personal destacan factores de riesgo como el elevado estrés y la ausencia de recursos para afrontarlo, altos niveles de ansiedad, estado de ánimo negativo, falta de disfrute de la práctica y pobres habilidades para las relaciones (Berengüi, 2018). Otros autores, como González-Hernández, (2019) también valoran los altos niveles de perfeccionismo. Por otro lado, a nivel social afecta la relación con el entrenador, el bajo apoyo social, las altas exigencias competitivas, las elevadas demandas de tiempo dedicadas al deporte, así como el aburrimiento- monotonía durante el entrenamiento (Berengüi, 2018). Por otro lado, resulta relevante la investigación de Martínez de Quel et al; (2019), quienes quisieron identificar los factores que los propios niños perciben

como estresantes en su práctica deportiva. Durante el entrenamiento, los factores más mencionados fueron las exigencias, el favoritismo por parte del entrenador, la falta de tiempo para realizar otras actividades y el cansancio físico. En la competición, reportaron experimentar emociones negativas y preocupación como los factores que más les generan estrés. Sin duda la mayor preocupación en el estudio sistemático del burnout es su relación con el abandono de la práctica deportiva, puesto de manifiesto desde la perspectiva motivacional por Garcés de Los Fayos y Cantón (1995).

2.2.4. Consumo de sustancias nocivas

Relevancia

El consumo de sustancias nocivas en el ámbito deportivo juvenil representa una problemática de creciente preocupación debido a sus implicaciones tanto a corto como a largo plazo en la salud y el desarrollo de los jóvenes atletas. El uso de esteroides anabólicos, estimulantes y drogas recreativas con el propósito de mejorar el rendimiento deportivo puede derivar en consecuencias severas: daño hepático, complicaciones cardiovasculares, trastornos hormonales y alteraciones conductuales, tales como agresividad y depresión. Estas prácticas no solo ponen en riesgo la salud física y mental de los jóvenes, sino que también erosionan los principios de ética y fair play fundamentales en el deporte. (Ortega Ruiz, V. 2018). El dopaje es un fenómeno que se inició a principios de los años sesenta y su erradicación continúa siendo un desafío en nuestra sociedad. Pese a pensar que el dopaje es circunstancia propia de adultos, la prevalencia en niños y adolescentes que practican deportes se estima entre el 3% y el 5%. (Roldan et al, 2019). Estos porcentajes se distribuyen con mayor prevalencia en aquellos que juegan el alto nivel competitivo. Los tres ejes básicos que conforman el antidopaje son: el legislativo, el biomédico y el psicosocial. Sobre este último

ahondaremos para conocer los factores de riesgo y protectores de esta práctica. (Ortega Ruiz, V. 2018).

Factores de riesgo

Entre los factores personales de riesgo del consumo de drogas se encuentra que la impulsividad y la búsqueda de sensaciones son asociadas con un mayor riesgo de consumo de estas sustancias nocivas e ilegales. (Sekri, H.,2021). Asimismo, para el dopaje puede predisponer tener una identidad única sobre en relación con el deporte, escasez de vínculos afectivos seguros, bajo autocontrol, búsqueda de sensaciones y alta presión (García-Grimau, E). Para finalizar este bloque cabe recalcar la relativa facilidad de acceder a cualquier droga prohibida. (Ortega Ruiz, V. 2018). Por tanto, un trabajo de prevención e informativo resulta esencial (Anshel y Russell, 1997) así como una actitud de desaprobación del consumo por parte de sus iguales (Sekri, H.,2021)

2.2.5. Agresividad y violencia

Relevancia

La violencia frente a la infancia y adolescencia es una realidad en ocasiones oculta, silenciada y subestimada. La mayor parte de la violencia se produce en relaciones cercanas y afectivas, siendo difícil de detectar por la intimidad de los ámbitos en los que tiene lugar. (OMS, 2020). Por otro lado, la violencia en el deporte se extiende desde el deporte de competición a cualquier práctica física y es vinculada a todo el entorno deportivo: jugadores, entrenadores, árbitros, espectadores, familias, Federaciones, clubes deportivos e instituciones públicas como máximos responsables. (Martínez-Sánchez et al; 2021). El colectivo infanto-juvenil es el mayor vulnerable para sufrir violencia en el deporte. (UNICEF, 2021)

No son casos aislados. El proyecto CASES (Hartill et al, 2021) estudia la prevalencia y características de la violencia interpersonal contra la infancia y

adolescencia (IVAC) en seis países europeos. En el caso de España, las experiencias de violencia fuera del deporte ascienden al 84% y dentro del deporte tienen datos del 78%. La experiencia más común de IVAC en el deporte fue la violencia psicológica (70%), seguida por la física (43%), sexual sin contacto (36%), negligencia (34%), y por último la violencia sexual con contacto (20%). (Hartill et al, 2021).

La violencia es un término amplio, que incluye desde la acción: violencia física, psicológica, sexual, hasta la no-acción. Dentro de las relaciones interpersonales en función de la autoría se podría hablar de descendente (de persona adulta hacia menor) u horizontal (entre iguales). Además, va más allá de lo interpersonal: violencia institucional, estructural o de prácticas tradicionales nocivas. Serían ejemplos clubes que fomentan una competitividad extrema o inserta en modelos pedagógicos dañinos (como el uso de castigo físico). (UNICEF, 2021).

Factores de riesgo

La agresividad en el deporte puede ser provocada por varios factores de riesgo que abarcan desde la relación entrenador-deportista, la presión excesiva por los resultados, la comunicación y la influencia familiar. Un estilo autoritario y rígido del entrenador, con falta de flexibilidad y normas estrictas, incrementa los niveles de agresividad en los jóvenes (Martínez-Sánchez et al., 2021; Smoll y Smith, 2002). Las críticas constantes, insultos y humillaciones deterioran la autoestima de los atletas y pueden incitar respuestas agresivas (Côté y Gilbert, 2009; Horn et al., 2007). El favoritismo de algunos entrenadores genera resentimiento y comportamientos agresivos entre los deportistas (Smith y Smoll, 2019; Smith et al., 2006). La falta de comunicación y apoyo emocional entre el entrenador y el deportista es otro factor crítico que puede llevar a actitudes hostiles (Carron et al., 2018; Jowett y Cockerill, 2003; Gano-Overway et al., 2009). Además, la presión excesiva por ganar, tanto por

parte de entrenadores como por la cultura deportiva, aumenta el estrés y la agresividad (Côté y Baker, 2007; Gucciardi et al., 2017). La exclusión social dentro del equipo puede causar sentimientos de ira y frustración en los atletas marginados (Holt y Dunn, 2020; Weiss, 2011). Finalmente, la presión y expectativas poco realistas de la familia, junto con la falta de apoyo y afecto, influyen profundamente en los comportamientos agresivos de los deportistas (Smith et al., 2017; Crane y Temple, 2015; Martínez-Sánchez et al., 2020; Carron et al., 2018).

2.2.6. Ausencia de salvaguarda

La promoción de la salvaguarda de la infancia y la adolescencia en el ámbito deportivo es fundamental, además de constituir una obligación legal según la LOPIVI. Uno de los factores de riesgo más críticos es la carencia de mecanismos de denuncia eficaces ante posibles situaciones de maltrato (Smith y Smoll, 2019; Hartill, 2014). La ausencia de canales adecuados, accesibles y adaptados no solo obstaculiza la intervención temprana, sino que también puede perpetuar un ciclo de abuso y agresividad. Además, la falta de diversidad e inclusión en el ambiente deportivo perpetúa estereotipos y comportamientos excluyentes (Cunningham, 2019).

Por otro lado, se abordan diversos factores de riesgo relacionados con la formación. La escasa educación de los deportistas sobre sus derechos agrava la situación, ya que muchos niños y adolescentes desconocen sus derechos y los recursos disponibles para protegerse del maltrato (Davidson, 2005; ONUDD, 2019). Asimismo, la carencia de programas de bienestar y salud mental constituye un aspecto crítico (Rice et al., 2016; Gulliver et al., 2012). Por último, la falta de formación de todos los actores del deporte en temas de maltrato y protección infantil subraya la necesidad de una educación más amplia y sistemática para prevenir el maltrato en el ámbito deportivo (Consejo de Europa, 2017).

Otro factor significativo es el clima organizacional deportivo, que, cuando tolera o incluso ignora el maltrato, propicia una cultura del silencio y normaliza la violencia. En muchas organizaciones deportivas, existe una reticencia a abordar y sancionar comportamientos abusivos, lo cual refuerza la impunidad y desanima a las víctimas a denunciar (Vertommen et al., 2017; Mountjoy et al., 2016; Martínez-Sánchez et al., 2021). La existencia de políticas de salvaguarda conocidas por todos los miembros del club resulta crucial para avanzar hacia una cultura de protección (Côté y Gilbert, 2009; Kerr y Stirling, 2012).

2.3. Políticas de salvaguarda en el deporte para la infancia y adolescencia

Los poderes públicos y las entidades de defensa de los derechos del niño promueven y promulgan un ámbito y una legislación que sirva de marco y referencia para la protección a la infancia y adolescencia, también en el deporte. La protección de las personas menores de edad es una obligación prioritaria de los poderes públicos, reconocida en el artículo 39 de la Constitución Española y en tratados internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 y ratificada por España en 1990. La nueva Ley Orgánica 8/2021, introduce nuevos avances y cambios en esta materia. En la Comunidad de Madrid corresponde a la Ley 4/2023, de 22 de marzo.

2.3.1. LOPIVI en el ámbito deportivo.

La LOPIVI plantea un nuevo paradigma de protección integral de forma holística, es decir, a lo largo de todos los momentos del proceso, incidiendo en la prevención, sensibilización, detección, comunicación, y reparación del daño. La aprobación de tal ley no solo responde a la necesidad de introducir en nuestro ordenamiento jurídico el cumplimiento de los compromisos internacionales en protección integral de menores, sino que, además, muestra la relevancia de una materia

que conecta de forma directa con el sano desarrollo de nuestra sociedad y la agenda 2030. Incorpora la obligatoriedad de nuevas figuras; el coordinador de bienestar en el ámbito educativo y el delegado de protección en el ámbito del deporte y del ocio. En el artículo 48 (ver. Anexo 1) se introduce esta y otras obligaciones para las entidades que realizan actividades deportivas o de ocio con personas menores de edad de forma habitual. Se fundamenta en el enfoque de Derechos, la erradicación de la violencia, el fomento del buen trato y la creación de entornos seguros.

El enfoque de Derechos, se basan en cuatro principios fundamentales: 1- la no discriminación, 2- el interés superior del niño, 3- el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo y 4- la participación (UNICEF, 2015). Que a su vez se clasifican en tres grupos (las 3 P): de Provisión o prestación (referidos a la satisfacción de necesidades básicas), de Protección (contra actos perjudiciales) y de Participación (el derecho a intervenir en decisiones que son de su interés). Todo ello queda recogido y desarrollado en los 54 artículos que componen la Convención de Derechos del Niño (Ver Anexo 2)

El deporte es un lugar privilegiado para observar y detectar, pero, especialmente para prevenir la violencia y no generalizarla (Hartill et al., 2021). La violencia se define como “toda acción, omisión o trato negligente que priva a las personas menores de edad de sus derechos y bienestar, que amenaza o interfiere su ordenado desarrollo físico, psíquico o social, con independencia de su forma y medio de comisión, incluida la realizada a través de las tecnologías de la información y la comunicación, especialmente la violencia digital.” (LOPIVI)

La LOPIVI promueve erradicar la violencia y promover una cultura de buen trato. Esta forma de relacionarse debe cumplir con los principios de respeto mutuo, dignidad del ser humano, convivencia democrática, solución pacífica de conflictos,

derecho a igual protección de la ley, igualdad de oportunidades y prohibición de discriminación (LOPIVI).

Por último, la LOPIVI recoge la creación de entornos seguros como una prioridad. Define este entorno como “aquel que respete los derechos de la infancia y promueva un ambiente protector físico, psicológico y social, incluido el entorno digital” (LOPIVI). Aunque existen entornos que permiten la supervivencia y cierta evolución, el desarrollo pleno de la persona solo se alcanza cuando el entorno es seguro y protector en los cuatro niveles fundamentales planteado entre UNICEF y Espirales Consultoría de Infancia, como política de prevención. (UNICEF, 2021):

- Nivel 1: entornos físicos seguros y protectores.
- Nivel 2: entornos emocionales seguros y protectores.
- Nivel 3: personas adultas conscientes.
- Nivel 4: la participación de todas las personas, incluidos niños, niñas y adolescentes.

En suma, la LOPIVI se caracteriza por tres elementos esenciales que inspiran de manera transversal todo su articulado: su integralidad, pues abarca todos y cada uno de los ámbitos en los que la infancia y adolescencia desarrollan su vida, al igual que se extiende a cualquier clase de medidas, ya sean formativas, preventivas o de detección precoz; su enfoque de derechos, llamado a reconocer la dignidad de la persona, con independencia de su condición etaria; y, finalmente, su manifiesta voluntad por erradicar, más que castigar, la violencia, para con ello dar debida respuesta a la Meta 16.2 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) (Ballesté,& Mallol, 2023).

3. Desafíos en la aplicación de la salvaguarda en el deporte

Lo cierto es que la aprobación de la LOPIVI tan solo ha supuesto uno de los primeros pasos, de los múltiples que deben darse, para propender a un cambio efectivo de paradigma social que venga a erradicar la violencia contra la infancia y la adolescencia en cualquiera de sus manifestaciones (Ballesté & Mallol, 2023). En primer lugar, parece que disfrutar de un deporte seguro, saludable, inclusivo y divertido conlleva múltiples beneficios para la infancia y adolescencia por lo que se debe favorecer y fomentar que el deporte de formación cumpla con estos requisitos. En segundo lugar, es necesario desarrollar los diferentes mecanismos e instrumentos que la ley dispone para prevenir la violencia e implementar en los diferentes niveles administrativos - estatal, autonómico y local - (Martínez & Escorial, 2021). En tercer lugar, específicamente en el ámbito deportivo, se deben tomar en consideración los riesgos que por sí mismo puede conllevar el deporte. (Berengüi, 2018).

La cultura organizacional de salvaguarda hace referencia al conjunto de suposiciones, creencias, valores y actitudes subyacentes compartidos por los miembros de una organización, que interactúan con las estructuras y sistemas de una organización y el entorno contextual más amplio para dar como resultado aquellas prácticas externas, fácilmente visibles, que influyen en la seguridad (Owusu-Sekyere, F.,2022) Sin embargo, la cultura de la competitividad y centrada en los resultados, propia del deporte, dificulta a los clubes deportivos apostar verdaderamente por la salvaguarda a los menores (Martínez Sanchez, et al 2021). Por otro lado, aunque los clubes pretendan generar cambios hacia la salvaguarda, quizás por si solos son incapaces, al no disponer de herramientas necesarias para ello (Martínez & Escorial, 2021).

En la aplicación real de las medidas de salvaguarda se detectan, por lo menos, dos grandes dificultades en el ámbito deportivo: la cultura del deporte orientada al

resultado y la competición, y la ausencia de herramientas accesibles para los clubes que les sirva como diagnóstico. El campo de la psicología deportiva puede (y debe) contribuir en la generación de instrumentos de evaluación y participar en el cambio cultural hacia la salvaguarda.

4. Metodología

A continuación, se presenta CHASSE (del inglés Children and Adolescents Safeguarding risks Self-assessment in sport organizations), un instrumento elaborado por el grupo de investigación *PSIDEP UAM*, que sirve para la autoevaluación de riesgos deportivos que atentan contra la salvaguarda de la infancia y adolescencia; facilitando la labor de los clubes deportivos y ayudando a ser efectivo el cambio cultural.

4.1. Objetivo

El objetivo del instrumento es la detección temprana por parte de los clubes de amenazas que pueden atentar contra la integridad, el disfrute y el mantenimiento de la práctica deportiva para la infancia y adolescencia, asimismo favoreciendo un deporte seguro, sano, inclusivo y divertido. El objetivo es que los mismos clubes tengan herramientas para poder realizar su autoevaluación siguiendo las indicaciones del protocolo-

4.2. Procedimiento

4.2.1. Diseño del instrumento

El sistema pretende ser una herramienta fácilmente administrable y accesible para los clubes. Los pasos previos al diseño final del instrumento conllevaron una revisión amplia de la literatura tanto a nivel de legislaciones sobre el deporte y la LOPIVI, como ampliando la mirada a la violencia, para finalizar con encontrar las principales circunstancias que atentan contra la salvaguarda en el deporte. Para ello, se

revisó la literatura sobre psicología del deporte; estudios empíricos, metanálisis, documentos de posición, reseñas de literatura, capítulos de libros y tesis doctorales que hablaran sobre las circunstancias escogidas y sus factores de riesgos, en la medida de lo posible, lo más adaptado para este colectivo.

Una vez con la información recolectada se pensó la forma de identificar con ítems sencillos cada uno de los factores de riesgo. En este punto se encontraron algunos de ellos inmodificables, como por ejemplo el sexo, sobre los que no se crearon ítems específicos. Sin embargo, conocer que ser mujer es factor de riesgo para TCA en actuaciones futuras podría orientar o reforzar la actuación para ellas. También se procedió a un descarte de factores considerados extremadamente difíciles de detectar para los futuros informante como el tipo de personalidad, más aún cuando la idea es evaluar clubes deportivos y la diversidad de personas que los conforman.

Este estudio fue aprobado por el Subcomité de ética de la Universidad Autónoma de Madrid (Ver Anexo 3).

A. Niveles

En base a la bibliografía y la realidad de los clubes se determina necesario crear una diferencia a nivel organizacional (o de club) y para cada uno de los equipos (o grupos). A nivel organizacional se identifican factores macros, relacionados con la estructura y cultura del club. Sin embargo, a nivel de equipos, se pretende identificar si la actividad en sí es segura. En este nivel el rol desempeñado por el entrenador o técnico resulta relevante en el desarrollo de esta, así como la dinámica propia del grupo.

B. Bloques

Se decide establecer cuatro bloques, sugeridos de tal como la LOPIVI define entorno seguro (ver en página 8). Los nombres escogidos son los siguientes:

- Bloque 1: Entornos físicos de seguridad y protección en menores
- Bloque 2: Entornos emocionales de seguridad y protección en menores
- Bloque 3: Formación y sensibilización
- Bloque 4: Participación

El número de ítems para cada bloque varía; siendo 9, 5, 7 y 4 respectivamente en el organizacional, mientras que 9, 10, 4 y 4 para el nivel de equipo. Asimismo, el instrumento cuenta con un bloque 0 donde se recogen datos identificativos del informante y el club o equipo sobre el que se informa.

Asimismo, antes de finalizar se incluye una pregunta donde deben dar el porcentaje que consideren que su club cumple con las medidas de protección y salvaguarda.

C. Variables

Las variables que se evalúan en CHASSE son las siguientes condiciones problemáticas que atentan con la salvaguarda en el deporte de la infancia y adolescencia:

1. Lesiones
2. TCA
3. Burnout
4. Dopaje
5. Agresividad y violencia
6. Salvaguarda

Las cinco primeras corresponden propiamente a riesgos de la práctica deportiva mientras que la última es propia de cumplir y favorecer el proceso de salvaguarda. Los ítems corresponden a los indicadores observables de los factores de riesgo de estas condiciones. En el Anexo 4 puede ver los factores de riesgo para cada condición.

De cada una de las condiciones, tras la revisión bibliográfica, se destacan varios factores de riesgos, y es de cada factor de riesgo de los que se crean uno o varios indicadores observables. A continuación, en la tabla 1, se muestra un ejemplo para el primer factor de riesgo; lesiones deportivas.

Tabla 1

Fundamentos bibliográficos de CHASSE

CONDICIÓN	Factor de Riesgo	Fuente(s)	Indicador observable	Número de ítem
1.Lesiones deportivas	1.1. Lesiones previas	Frisch et al 2009	Se cuenta con un registro de lesiones y otras condiciones médicas de los jugadores del club que permita adaptar la actividad a las condiciones físicas concretas de cada deportista.	IA5

Tabla 1. Fundamentos bibliográficos de CHASSE

En este caso, las lesiones previas solo tienen un indicador observable, el ítem IA.5. Pero, para otros casos pueden existir más de un indicador o un indicador para varios factores de riesgo. En las tablas del Anexo 5 y Anexo 6 se puede ver como cada ítem está asociada a una condición y uno o varios factores de riesgo.

4.2.2. Instrucciones

Se diseñan unas instrucciones generales para que el club disponga con anterioridad a cumplimentar los instrumentos. En ellas se explican los objetivos de la herramienta, sus dos niveles y las indicaciones sobre quien serían los informantes ideales que debieran responder. (Ver Anexo 7). Se posibilita tanto la participación online o en papel.

Por otro lado, también se cuenta con instrucciones específicas para cada nivel de la forma de cumplimentar el instrumento. Se explica que se divide en IV bloques, que se debe escoger una de las cuatro opciones por ítems y se da un ejemplo. (Ver Anexo 8 para el nivel organizacional y ver Anexo 9 nivel equipo). Las opciones de respuesta posible son cuatro: Sí, No, Parcialmente y No aplica, codificadas respectivamente como 1, 2, 3 y 4. En la opción Parcialmente se obliga a escribir los aspectos que hacen que no se cumpla con esa condición.

4.3. Participantes

Los participantes son escogidos por accesibilidad a la muestra, siendo clubes con los que existía una relación anterior al estudio piloto, lo que además ha facilitado poder contar con una evaluación externa, por parte de un participante de este grupo de investigación en el nivel organizacional. En total, han participado tres clubes deportivos de la Comunidad de Madrid, como se muestra reflejado en la tabla 2.

Los clubes 1 y 1 son clubes deportivos de fútbol, que imparten fútbol 7 y fútbol 11. En cambio, Club 3 es un club deportivo escolar que cuenta con diferentes deportes: fútbol sala, baloncesto, gimnasia, baile moderno, natación, judo, patinaje y floorball. Estos datos también son recogidos por el instrumento en un bloque general, fuera de los propios sobre salvaguarda. En la medida de lo posible, posterior a la cumplimentación de la herramienta, se tuvo una sesión de feedback con algunos de los participantes.

Tabla 2.

Respuestas obtenidas en el estudio piloto.

CLUB- CHASSE	Organizacional	Equipo (entrenadores*)
Club 1	<u>Presidente</u> ¹	Prebenjamín A
	<u>Director deportivo</u>	<u>Prebenjamín B</u>
	<u>Encargado de materiales</u>	Benjamín B
	<u>Delegado de protección- Secretario</u>	<u>Alevín C</u>
		<u>Cadete B</u>
	Externo: psicología (psic.)	<u>Juvenil C</u>
Club 2	Presidente ²	Prebenjamín Futsal
	Coordinador	Alevín masculino Futsal
	Coordinador Futsal	Futsal femenino
		Alevín femenino Basket
	Externo: delegado protección/psic.	Cadete femenino Basket
Club 3	Coordinadora	
	Coordinador	
	Coordinador F7	
	Externo: psicología	
Respuestas totales	13	11

Nota. *Elaboración propia*

¹ Subrayado indica que se administró para esos participantes CHASSE en papel.

² Sin subrayar indica que se administró para ese participante CHASSE en formato digital.

4.4. Niveles de riesgo

Los ítems del nivel organizacional están formulados siendo su respuesta negativa motivo de riesgo. Se plantea, en este primer punto, una evaluación del riesgo siguiendo los colores de un semáforo para indicar la gravedad de las amenazas frente a la salvaguarda. El color rojo representará una situación de alto riesgo; donde solo se cumple entre el 0-45% de medidas de salvaguarda, el amarillo implica que el riesgo es moderado y debe vigilarse (entre un 45-75%) y verde significa que el riesgo es bajo, siendo satisfactorio (intervalo de porcentaje de cumplimiento de medidas entre el 75% y 100%). Para calcular esta evaluación del riesgo se escogen solo las respuestas afirmativas (donde la respuesta ha sido Sí).

5. Resultados

Los resultados de este estudio piloto incluyen las respuestas por parte de los tres clubes deportivos participantes, así como un análisis de los niveles de acuerdo entre informantes de un mismo club, con el objetivo de poder tener datos de fiabilidad. En cada club participaron 4 informantes ($n=4$), a excepción del primer club, Club 1, donde lo hicieron 5 ($n=5$).

En la tabla 3 aparecen los principales resultados, calculados en forma de porcentaje sobre la media de respuestas, para cada club. Las primeras columnas subrayadas de color hacen referencia a cada uno de los cuatro bloques en los que se divide el instrumento, mientras que la columna séptima corresponde al nivel de salvaguarda general real.

La columna sexta recoge el porcentaje medio que los informantes dieron en la última pregunta sobre el nivel considerado de cumplir con medidas de salvaguarda,

mientras que la columna séptima recoge el porcentaje a partir de las puntuaciones objetivas (sobre el total el número de Sí (1)) dadas por los informantes.

El intervalo de riesgo se ha calculado utilizando como límite inferior el porcentaje de respuestas No (2) y el límite superior como la suma de los porcentajes de respuestas seleccionadas como No (2), Parcialmente (3) y No disponible (4). El color; rojo, amarillo y verde, se recuerda que indica la gravedad en intervalos de riesgo; alto riesgo, riesgo moderado y bajo riesgo.

Tabla 3.

Principales resultados de CHASSE-Organizacional

	Nº	Bloque I	Bloque	Bloque	Bloque	%Salv	%Salv.	Intervalo
	NNA ¹	(9) ²	II(5) ³	III (7) ⁴	IV (4) ⁵	Subj ⁶	Real ⁷	riesgo ⁸
Club1 (n=5)	400	6,2 (69%)	4,6 (92%)	6,8 (97%)	3,8 (95%)	85	21,4 (85,6%)	14,4-10,4
Club2 (n=4)	200	1,75 (19%)	2,25 (45%)	2 (28%)	2 (50%)	60	8 (32%)	68- 38,8
Club3 (n=4)	850	4,75 (53%)	3,75 (42%)	4 (57%)	2,25 (56%)	83	14,4 (57,4%)	42,6-13

Nota. *Elaboración propia*

Visualmente se puede ver como el primer club, Club 1, muestra los resultados más favorables de salvaguarda. Es en el bloque I; Entornos físicos de seguridad y protección, donde presenta la puntuación más baja. Aun así, en este bloque cumple en un 69% las condiciones favorables. Para el resto de los bloques cumple las condiciones de manera favorable en porcentajes superiores al 90%. El porcentaje real de salvaguarda corresponde con el propiciado por los informantes; un 85%.

Por otro lado, el club 2 muestra resultados preocupantes para los tres primeros bloques y quedando al límite en el bloque de participación. El porcentaje de salvaguardia real del club, sacado a partir del porcentaje de ítems cumplidos (tomados estos como 1) es de un 32% pese a ser la media de los informantes de un 60%. En el bloque I solo cumple con las condiciones favorables en un 19%, para el bloque II en un 45%, en el III un 28% y el bloque IV obtiene la puntuación más alta con un 50%.

Por último, los resultados del club más grande (CF), que cuenta con 850 menores, alertan que deben vigilarse varios aspectos. El cumplimiento real de las medidas de salvaguarda es de un 57,4%, inferior a su estimación subjetivamente con un 83%. Cumplimentan de manera favorable los bloques con porcentajes medios; un 53%, 42%, 57% y 56%, respectivamente para los cuatro bloques.

Se considero útil, en este momento del estudio piloto, poder tener medidas de fiabilidad del instrumento para recoger el grado de acuerdo entre los agentes evaluadores y el acuerdo de alguno de ellos con el informante externo. En la tabla 4 se muestran los resultados tras el análisis con R Analytics. Coeficiente Kappa de Fleiss, mide el grado de confiabilidad para múltiples evaluadores, versión del Coeficiente Kappa de Cohen, entre dos evaluadores.

Tabla 4

Resultados fiabilidad- nivel organizacional

	Club 1	Club 2	Club 3
Kappa de Fleiss	0,328	0,686	0,411
p-value	3.5e-10	5.3e-07	0.000368
Kappa de Cohen	0,752	0.802	0,191
IC	0,43-1	0,58-1	0,04-0.34
p-value	0.000103	6.13e-05	0.0129

Para el primer club, Club 1, los resultados indican que hubo un nivel de acuerdo moderado (Kappa de Fleiss= 0.328) entre los 4 evaluadores internos para los 25 ítems del instrumento a nivel organizacional, siendo este acuerdo estadísticamente significativo ($p\text{-value} < 0.05$). Los resultados entre el informante externo y el presidente muestran un intervalo de confianza de 0,43 a 1, con Kappa de Cohen = 0.752. Este acuerdo es altamente significativo ($p\text{-value} < 0.05$), lo que sugiere que el acuerdo observado no es debido al azar y es considerablemente real. Además, el intervalo de confianza sugiere que, incluso en el peor de los casos, el acuerdo es justo, y en el mejor de los casos, es perfecto.

En el Club 2, el segundo club y más pequeño, se encuentra el mayor acuerdo Kappa de Fleiss=0,686 entre los 3 informantes internos. El acuerdo con el informante exterior y el presidente tiene un intervalo de 0,58 a 1. Siendo Kappa de Cohen = 0.802. Este acuerdo es altamente significativo ($p\text{-value} < 0.05$) y considerable, sugiere que, en el peor de los casos, el acuerdo es casi perfecto, y en el mejor de los casos, es perfecto.

Para el tercer club evaluado, CF, se obtiene un Kappa= 0.411 entre los 3 evaluadores internos, siendo este acuerdo estadísticamente significativo ($p\text{-value} < 0.05$). Por otro lado, el acuerdo entre el evaluador externo con la moda de los evaluadores internos es leve (Kappa = 0.191), este acuerdo es significativamente mejor que lo que se esperaría por azar ($p\text{-value} < 0.05$).

6. Discusión

El objetivo del estudio piloto fue la elaboración de un instrumento accesible para los clubes, para que ellos mismos pudieran realizar una autoevaluación de los factores de riesgo principales.

Los resultados sobre la fiabilidad del instrumento muestran resultados favorables para todos los casos, con mayor o menor acuerdo, son significativos y por tanto no parecen deberse al azar. En el tercer club se encuentran los resultados menos favorables de acuerdo con el evaluador externo. Se ve que es más exigente el evaluador externo, respondiendo más ítems como no cumple (2), en comparación a los evaluadores internos, quienes marcan las mismas circunstancias como positivas (1). Esta realidad, se da en los tres clubes, pero es más llamativa para el Club 3. Además, cabe recordar, que Club 3 es el club más grande, quizás pueda ser otro factor explicativo de menor acuerdo al no tener un conocimiento tan completo. Por el otro lado, el Club 2 es el club más pequeño y muestra los acuerdos más altos.

Aunque los criterios psicométricos, en este estudio piloto, se consideren inferiores al de utilidad, se puede concluir que los resultados encontrados sobre los acuerdos no son debidos al azar y son mayoritariamente moderados, aunque existe menor acuerdo en los clubes más grandes.

Por otro lado, durante la administración de los instrumentos y posterior al mismo, se recogió feedback de los propios informantes, quienes valoraron de manera positiva participar del estudio piloto. De hecho, los presidentes de los Club 1 y Club 2 quisieron contar con el instrumento, se mostraron interesados de seguir participando y poder tener una retroalimentación. En alguna ocasión mientras lo cumplimentaban comprobaron que eso fuera así, como con el estado del desfibrilador, explicitando en alto “esto es importante”.

Asimismo, los participantes que realizaron su participación en formato online relataron que fue “sencillo, intuitivo y útil”. Uno de los coordinadores expuso que fue “una encuesta muy buena y para reflexionar de muchas cosas...”. Estas experiencias

ponen de manifiesto lo encontrado en la literatura sobre la ausencia de herramientas actuales y accesibles sobre este ámbito (Martínez & Escorial, 2021).

Asimismo, se detectó una preocupación real a las problemáticas que se trataban. Los clubes parecen ser conscientes de las circunstancias negativas que puede desencadenar el deporte y quieren disminuir su probabilidad, al menos desde la parte de la directiva y coordinación, con quien se puede tener una conversación posterior.

7. Conclusiones

Como se ha ido viendo, la salvaguarda a la infancia va mucho más allá de la prevención del abuso físico y sexual, puesto que existen otras manifestaciones de la violencia en el deporte de forma más recurrente y en ocasiones normalizada (Hartil, 2021). Se han obtenido resultados de tres clubes donde se manifiestan, para los tres, posibles indicadores de factores de riesgo que atentan contra la seguridad, la salud, la inclusión y la diversión de infancia y adolescencia en el deporte.

CHASSE ha sido, en este estudio piloto, una herramienta accesible, sencilla y útil, tal como han informado los participantes tanto en versión digital como en papel. Asimismo, se ha encontrado niveles moderados y significativos de fiabilidad en las respuestas.

En conclusión, CHASSE es un sistema innovador, sencillo y necesario, que podrá ser realmente útil para los clubes deportivos. Pues les dota de las herramientas necesarias en la detección precoz y les guiará en los cambios necesarios que ellos mismos podrán realizar para ser clubes que fomentan la salvaguarda en menores y que reducen riesgos.

8. Limitaciones y líneas futuras de trabajo e investigación

El presente estudio piloto presenta algunas limitaciones. Lo primero, cabe recalcar la ausencia de instrumentos similares ya creados con los cuales poder comparar. En segundo lugar, la muestra quizás es pequeña y solo contempla clubes de deportes colectivos. Una muestra mayor permite tomar resultados más significativos, así como contar con clubes de deportes individuales o con mayor diversidad podría informar si CHASSE es útil también para estos deportes. Quizás, podría entenderse como limitación la estructura no claramente definida sobre la toma de feedback posterior de los informantes por falta de tiempo.

A nivel equipo se obtuvieron respuestas, pero no de todo el club. Asimismo, los informantes fueron los propios entrenadores, lo que cabría estudiar quien debiese informar en esta parte por quizás verse sesgadas las respuestas. De modo que por estas razones no se analizan los datos a nivel Equipo. Por último, cabe destacar como limitaciones las creencias previas sobre el castigo o penalización por no cumplir con la LOPIVI, lo que puede llegar a sesgar de manera favorable las respuestas, no siendo sincero y no dotando de la relevancia que se merece esta materia.

Con este trabajo se abren grandes frentes con los que continuar avanzando en materia de salvaguarda en el deporte y el cumplimiento real de las obligaciones de la LOPIVI. En cuanto al ámbito de la investigación, se sugiere ahondar en la validez del instrumento y perfeccionarlo, si fuera así considerado por otro grupo de expertos diferente al propio creador. También, se sugiere continuar con el diseño de la corrección del instrumento con la cual definir el grado de riesgo, para poder ser comunicado al club en forma de diagnóstico detallado.

Teniendo en cuenta los múltiples pasos que deben darse en materia de protección a la infancia y adolescencia, y de manera específica en el deporte, resulta relevante la

colaboración futura de la psicología deportiva. En su vertiente más práctica, se despliega un amplio trabajo de prevención, acompañamiento y actuación en los clubes deportivos, posterior al conocimiento de su situación gracias a los resultados que CHASSE otorga. Asimismo, sería interesante plantear actuaciones específicas a las necesidades y realidades de cada club.

Para finalizar, este estudio piloto aporta una herramienta necesaria y útil para los clubes deportivos. Colabora tanto con la evaluación y detección temprana, como con la sensibilización de una realidad desagradable, ante la cual actualmente existen leyes en nuestra sociedad que fomentan un cambio. El deporte de formación verdaderamente puede ser seguro, saludable, divertido e inclusivo para la infancia y adolescencia. Ahora ya tenemos una herramienta para detectar los riesgos que pueden atentar contra ello. Sigamos dando pasos.

Referencias

- Aaltonen, S., Karjalainen, H., Heinonen, A., Parkkari, J., & Kujala, U. M. (2007). Prevention of sports injuries: systematic review of randomized controlled trials. *Archives of internal medicine*, 167(15), 1585-1592.
- Anshel, M. H., & Russell, K. G. (1997). Examining athletes' attitudes toward using anabolic steroids and their knowledge of the possible effects. *Journal of Drug Education*, 27(2), 121–145. <https://doi.org/10.2190/714T-AUM5-NEUL-8Y0Q>
- Aumaitre, A., Costas, E., Sánchez, M., Taberner, P., & Vall, J. (2021). Crecer saludablemente. Un análisis sobre la salud mental y el suicidio en la infancia y la adolescencia.
- Azofeifa, E. G. (2006). Motivos de participación y satisfacción en la actividad física, el ejercicio físico y el deporte. *MHSALUD: Revista en Ciencias del Movimiento Humano y Salud*, 3(1).
- Bailey, R. (2006). Physical education and sport in schools: A review of benefits and outcomes. *Journal of School Health*, 76(8), 397-401
- Ballesté, I. R., & Mallol, V. C. (2023). Estudios sobre la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. *Infancia y adolescencia*, (12).
- Beranek, V., Šťastný, P., & Nováček, V. (2021). School injuries and their prevention from the present perspective.
- Berengüi Gil. (2018). Capítulo 15. Problemas asociados a la práctica deportiva (Ed. EOS). Introducción a la Psicología del Deporte. (451- 490)

- Berengüi Gil. (2018). Capítulo 16. Práctica profesional de la Psicología del deporte. (Ed. EOS). Introducción a la Psicología del Deporte. (490-518)
- Berengüi Gil. (2018). Capítulo 5. Motivación (Ed. EOS). Introducción a la Psicología del Deporte. (124-153)
- Biddle, S. J., & Asare, M. (2011). Physical activity and mental health in children and adolescents: A review of reviews. *British Journal of Sports Medicine*, 45(11), 886-895
- Brackenridge, C. H., Kay, T., & Rhind, D. (2012). *Sport, children's rights and violence prevention: A source book on global issues and local programs*. Brunel University Press.
- Caine, D., Maffulli, N., & Caine, C. (2008). Epidemiology of injury in child and adolescent sports: Injury rates, risk factors, and prevention. *Clinics in Sports Medicine*, 27(1), 19-50. <https://doi.org/10.1016/j.csm.2007.10.00>
- Calvo, R (2002) *Anorexia y bulimia: guía para padres, educadores y terapeutas*. Barcelona: Planeta Paidós.
- Caracuel Cáliz, R., Alonso Vargas, J. M., Melguizo-Ibáñez, E., Salazar-Ruiz, M. R., & Ubago-Jiménez, J. L. (2023). Programas de prevención de lesiones en la clase de Educación Física: Una revisión sistemática. *Sportis. Scientific Journal of School Sport, Physical Education and Psychomotricity*, 9(3), 637-667.
- Carlin, M., & Garcés de los Fayos Ruiz, E. J. (2010). El síndrome de burnout: Evolución histórica desde el contexto laboral al ámbito deportivo. *Anales de Psicología / Annals of Psychology*, 26(1), 169–180. Recuperado a partir de <https://revistas.um.es/analesps/article/view/92171>

- Carlin, M., de Los Fayos, E. J. G., & de Francisco Palacios, C. (2012). El síndrome de burnout en deportistas: nuevas perspectivas de investigación. *Revista iberoamericana de psicología del ejercicio y el deporte*, 7(1), 33-49.
- Carron, A. V., Hausenblas, H. A., & Ebbeck, V. (2018). The importance of communication and emotional support in the coach-athlete relationship. *Psychology of Sport and Exercise*, 37, 102-110.
- Carron, A. V., Hausenblas, H. A., & Ebbeck, V. (2018). The importance of communication and emotional support in the parent-child relationship. *Psychology of Sport and Exercise*, 37, 102-110.
- Cohn, P. J. (1990). An exploratory study on sources of stress and athlete burnout in youth golf. *Sport Psychologist*, 4, 95-106
- Corliss Bean, Sara Kramers, Martin Camiré, Jessica Fraser-Thomas y Tanya Forneris | (2018) Desarrollo de una medida observacional que evalúa los procesos de calidad de los programas en el deporte juvenil, *Cogent Social Sciences*, 4:1, 1467304, DOI: 10.1080/23311886.2018.1467304
<https://doi.org/10.1080/23311886.2018.1467304>
- Côté, J., & Baker, J. (2007). The impact of an overemphasis on winning on the mental health and well-being of young athletes. *Journal of Sport Science and Medicine*, 6(2), 129-138.
- Côté, J., & Gilbert, W. (2009). Abusive coaching behaviours and their impact on young athletes' psychological well-being. *Journal of Sport & Exercise Psychology*, 31(2), 232-253

- Côté, J., & Gilbert, W. (2009). Tolerance of abusive behavior in sport: An organizational culture analysis. *Journal of Sport & Exercise Psychology*, 31(2), 232-253.
- Crane, J., & Temple, V. (2015). A systematic review of dropout from organized sport among children and youth. *European Physical Education Review*, 21(1), 114-131.
- de Los Fayos, E. J. G., Palacios, C. D. F., & Fernández, C. A. (2012). Inventario de burnout en deportistas Revisado (IBD-R). *Revista de Psicología del Deporte*, 21(2), 271-278.
- Díaz, J. D., & Díaz, D. C. (2012). Trastornos de alimentación en deportistas de alto rendimiento. Consejo Superior de Deportes, Servicio de Documentación y Publicaciones.
- Dorsch, T. E., Smith, A. L., McDonough, M. H., & Stark, A. M. (2009). The relationship of youth sport specialization with motivations for sport participation and sport commitment. *Journal of Sport and Exercise Psychology*, 31(4), 442-464.
- Durán, L. V. B., Segura, M. A. C., & Sancho, D. M. R. (2021). Actualización en trastornos de conducta alimentaria: anorexia y bulimia nerviosa. *Revista Médica Sinergia*, 6(08), 1-11.
- Feigley, D. A. (1984). Psychological burnout in high-level athletes. *Physician and Sport Medicine*, 12, 109-119.
- Fernández Cassi, C., & Pedrón, V. T. (2022). Asociaciones entre los estereotipos de género tradicionales y los trastornos de la conducta alimentaria durante la

- adolescencia y juventud: Una revisión sistemática. *Psicología Del Desarrollo*, (3), 51–77. <https://doi.org/10.59471/psicologia20221>
- Fernández, I. C., Marco, M. I. T., Merita, M. L. G., & Solá, I. B. (2003). Participación en deporte y salud percibida en la adolescencia. *Revista de psicología general y aplicada: Revista de la Federación Española de Asociaciones de Psicología*, 56(1), 77-88.
- Fernández, J.G; Contreras, O.R; García, L. M; González Villora, S (2010). Autoconcepto físico según la actividad fisicodeportiva realizada y la motivación hacia esta. *Revista Latinoamericana de Psicología*, 42 (2), pp 251-263
- Frisch, A., Croisier, J. L., Urhausen, A., Seil, R., & Theisen, D. (2009). Injuries, risk factors and prevention initiatives in youth sport. *British medical bulletin*, 92(1), 95-121.
- Gano-Overway, L. A., Newton, M., Magyar, T. M., Fry, M. D., & Kim, M. S. (2009). The influence of perceived motivational climate on moral reasoning and cheating frequency in youth sport. *Journal of Sport & Exercise Psychology*, 31(2), 135-149.
- Garcés de Los Fayos Ruiz, E. J. (1993). Frecuencia de burnout en deportistas jóvenes: estudio exploratorio. *Revista de psicología del deporte*, 2(2), 0055-63.
- Garcia, A. R., & Lee, S. M. (2020). Academic Achievement and Engagement in Youth Sports: Do They Have to be Mutually Exclusive? *Journal of Educational Psychology*, 112(2), 189-204

- García-Grimau, E., Casado, A., & de la Vega, R. (2020). Evolución de la investigación psicosocial del dopaje en el deporte de competición: una revisión narrativa (Evolution of doping in elite sport from the perspective of social sciences: a narrative review). *Retos*, 39, 973-980.
- García-Parra, N., González, J., & Garcés de los Fayos, E. (2016). Estado actual del estudio del síndrome de burnout en el deporte. *Cuadernos de Psicología del Deporte*, 16(2), 21–28. Recuperado a partir de <https://revistas.um.es/cpd/article/view/264351>
- Gledhill, A., Forsdyke, D., & Murray, E. (2018). Psychological interventions used to reduce sports injuries: a systematic review of real-world effectiveness. *British Journal of Sports Medicine*, 52(15), 967-971.
- Gould, D., & Carson, S. (2008). Life skills development through sport: Current status and future directions. *International Review of Sport and Exercise Psychology*, 1(1), 58-78.
- Gucciardi, D. F., Dimmock, J. A., & Holt, N. L. (2017). Perceived pressure in youth sport and its impact on the mental health and well-being of young athletes. *Journal of Adolescent Health*, 60(4), 428-434.
- Gucciardi, D. F., Dimmock, J. A., & Holt, N. L. (2017). The impact of the "win at all costs" culture on the well-being of youth athletes. *Journal of Adolescent Health*, 60(4), 428-434.
- Hallén A, Tomás R, Ekstrand J, et al UEFA Women's Elite Club Injury Study: a prospective study on 1527 injuries over four consecutive seasons 2018/2019 to 2021/2022 reveals thigh muscle injuries to be most common and ACL injuries

most burdensome. British Journal of Sports Medicine Published Online First:
05 January 2024. doi: 10.1136/bjsports-2023-107133

Hartill, M., Rulofs, B., Lang, M., Vertommen, T., Allroggen, M., Cirera, E.,
Diketmuller, R., Kampen, J., Kohl, A., Martín, M., Nanu, I., Neeten, M., Sage,
D., & Stativa, E. (2021). *CASES: General Report. The prevalence and
characteristics of interpersonal violence against children (IVAC) inside and
outside sport in six European countries*. Edge Hill University.
<https://doi.org/10.25416/edgehill.17086616.v1>

Hernández Londoño, M. (2017). Estado del arte en Colombia de los programas donde
se ha utilizado el Deporte para el Desarrollo y la construcción de la paz.
Ciencia, tecnología e innovación en salud, 1, 49-54

Holt, N. L., & Dunn, J. G. (2020). Fear of ostracism and its impact on motivation and
performance in youth athletes. *Psychology of Sport and Exercise*, 48, 101624.

Holt, N. L., & Dunn, J. G. (2020). Parental pressure and anxiety in youth athletes.
Journal of Sport and Exercise Psychology, 42(4), 321-330.

Horn, T. S., & Hasbrook, C. A. (2007). Psychological characteristics and their
development in Olympic champions. *Journal of Applied Sport Psychology*,
19(3), 312-333.

Horno, P., Romeo, F. J., Ferreres, Á., et al. (2017). *El acogimiento como oportunidad
de vida. Referentes de buena práctica y recomendaciones para una atención
idónea a niños, niñas y adolescentes en acogimiento familiar y residencial*.
Madrid: UNICEF Comité Español. Recuperado de
[http://www.espiralesci.es/investigacion-y-guia-de-buenas-practicassobre-
acogimiento-familiar-y-residencial-elaboradas-para-unicef-comite-espanol/](http://www.espiralesci.es/investigacion-y-guia-de-buenas-practicassobre-acogimiento-familiar-y-residencial-elaboradas-para-unicef-comite-espanol/)

- Janssen, I., & LeBlanc, A. G. (2010). Systematic review of the health benefits of physical activity and fitness in school-aged children and youth. *International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity*, 7(1), 40.
- Jeukendrup A, Cronin L. Nutrition and elite young athletes. *Med Sport Sci*. 2011;56:47-58. doi: 10.1159/000320630. Epub 2010 Dec 21. PMID: 21178366.
- Johnson, M. A., & Brown, L. S. (2018). The Dual Career of Young Athletes: Balancing Education and Sports. *International Journal of Sports Science & Coaching*, 13(4), 532-548.
- Jowett, S., & Cockerill, I. M. (2003). Olympic medalists' perspective of the athlete-coach relationship. *Psychology of Sport and Exercise*, 4(4), 313-331.
- Kerr, G., & Stirling, A. (2012). Child protection in sport: Reflections on thirty years of science and activism. *Social Sciences*, 1(1), 1-9.
- Knight, C. J., Neely, K. C., & Holt, N. L. (2011). Parental involvement in team sports: The good, the bad, and the ugly. *Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports*, 21(3), 833-840.
- Krahn, A. (2021). Psychological abuse in women's volleyball. In M. Lang (ed.), *Routledge Handbook of Athlete Welfare* (pp. 69-80). London, New York: Routledge.
- Martínez-de-Quel-Pérez, Ó., Sánchez-Moreno, A., Zamorano-Feijóo, C. y Ayán-Pérez, C. (2019). Epidemiología lesional en actividades escolares y extraescolares en la comunidad de Madrid (España). *Revista Internacional de Medicina y Ciencias de La Actividad Física y Del Deporte*, 19(73), 151.
<https://doi.org/10.15366/rimcafd2019.73.011>

- Martínez-Sánchez, A., López-Sánchez, G. F., & Lara-Cánovas, J. M. (2021). Cultura del silencio y maltrato en el deporte: voces de las víctimas. *Revista de Psicología del Deporte*, 30(2), 247-258.
- Martínez-Sánchez, A., López-Sánchez, G. F., & Lara-Cánovas, J. M. (2021). El estilo de liderazgo del entrenador y el burnout en jóvenes deportistas. *Revista de Psicología del Deporte*, 30(2), 247-258.
- Martínez-Sánchez, A., López-Sánchez, G. F., & Lara-Cánovas, J. M. (2020). The importance of parental support and affection in the development of young athletes. *International Journal of Sports Science & Coaching*, 15(5), 687-696.
- Maslach, C. y Jackson, S. E. (1981). *Maslach Burnout Inventory*. Palo Alto, California: Consulting Psychological Press.
- Mayer, J., Kühnle, F. & Thiel, A. (2021). Presenteeism in elite sport organisations: a framework for understanding athletes' decisions to practice sport despite Health concerns. In M. Lang (ed.), *Routledge Handbook of Athlete Welfare* (pp. 81-93). London, New York: Routledge.
- Mountjoy, M., Brackenridge, C., Arrington, M., & Blauwet, C. (2016). International Olympic Committee consensus statement: harassment and abuse (non-accidental violence) in sport. *British Journal of Sports Medicine*, 50(17), 1019-1029.
- Organización Mundial de la Salud (OMS). (2010). Recomendaciones mundiales sobre actividad física para la salud.
- Organización Mundial de la Salud. (2020). Informe sobre la situación mundial de la prevención de la violencia contra los niños 2020: resumen de orientación.

Ginebra: Organización Mundial de la Salud. Recuperado de:
<https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332450/9789240007154-spa.pdf>

- Orlando, L. M. (2023). *Deportista Amateur y Elite: ¿ mismas probabilidades de desarrollar TCA?* (Doctoral dissertation, Universidad ISALUD).
- Owusu-Sekyere, F., Rhind, D. J., & Hills, L. (2022). Safeguarding culture: towards a new approach to preventing child maltreatment in sport. *Sport Management Review*, 25(2), 300-322.
- Prieto-González, P.; Martínez-Castillo, J.L.; Fernández-Galván, L.M.; Casado, A.; Soporki, S.; Sánchez-Infante, J. Epidemiology of Sports-Related Injuries and Associated Risk Factors in Adolescent Athletes: An Injury Surveillance. *Int. J. Environ. Res. Public Health* 2021, 18, 4857.
<https://doi.org/10.3390/ijerph18094857>
- Roldan-Tabares, M. D., Herrera-Almanza, L., Serna-Corredor, D. S., & Martínez-Sanchez, L. M. (2019). Dopaje en deportistas: asunto de difícil manejo a nivel mundial. *Archivos venezolanos de farmacología y terapéutica*, 38(2), 1-8.
- Rössler, R., Donath, L., Verhagen, E., Junge, A., Schweizer, T., & Faude, O. (2014). Exercise-based injury prevention in child and adolescent sport: A systematic review and meta-analysis. *Sports Medicine*, 44, 1733-1748.
- Scanlan, T. K., Stein, G. L., & Ravizza, K. (1993). An in-depth study of former elite figure skaters: II. Sources of stress. *Journal of Sport and Exercise Psychology*, 15(2), 124-140.

- Sekri, H., & Aissa, E. (2021). Using sport for drugs abuse prevention. *Journal of Substance Abuse Prevention*, 8(3), 98-121
- Shaw, L., & Finch, C. F. (2017). Trends in pediatric and adolescent anterior cruciate ligament injuries in Victoria, Australia 2005–2015. *International journal of environmental research and public health*, 14(6), 599.
- Smith, J. K. (2019). The Importance of Education in the Sporting Career of Young Athletes. *Journal of Sports Sciences*, 15(3), 245-260.
- Smith, R. E., & Smoll, F. L. (2019). Perceived coach favoritism and its relationship to motivation and sport dropout in youth soccer players. *Journal of Sport and Exercise Psychology*, 41(1), 43-52
- Smith, R. E., Smoll, F. L., & Cumming, S. P. (2017). Parental expectations and burnout in youth athletes. *Journal of Sport and Exercise Psychology*, 39(2), 123-133.
- Smith, R. E., Smoll, F. L., & Curtis, B. (2006). Coach-athlete compatibility and athlete's perceptions of coaching behaviors. *Journal of Sport & Exercise Psychology*, 28(4), 437-455.
- Smith, R. E., Smoll, F. L., & Curtis, B. (2006). Coach-athlete compatibility and athlete's perceptions of coaching behaviors. *Journal of Sport & Exercise Psychology*, 28(4), 437-455.
- Smoll, F. L., & Smith, R. E. (2002). Coaching behavior research and intervention in youth sports. En T. Horn (Ed.), *Advances in sport psychology* (pp. 379-403). Human Kinetics.

- Smoll, F. L., & Smith, R. E. (2002). Coaching behavior research and intervention in youth sports. En T. Horn (Ed.), *Advances in sport psychology* (pp. 379-403). Human Kinetics.
- Smoll, F. L., & Smith, R. E. (2007). Coaching the coaches: Youth sports as a scientific and applied behavioral setting. *Current Directions in Psychological Science*, 16(1), 16-21
- Stirling, A.E. & Kerr, G.A. (2013). The perceived effects of elite athletes' experiences of emotional abuse in the coach–athlete relationship. *International Journal of Sport and Exercise Psychology*, 11(1), 87- 100. doi: 10.1080/1612197X.2013.752173
- Thompson, R. L. (2017). The Role of Clubs in Supporting the Educational Development of Young Athletes. *Instituto de Investigación Deportiva*. (Informe n.º 123).
- UNICEF (2021). *Ver para proteger. Claves para comprender la violencia contra niños, niñas y adolescentes y para desarrollar medidas de protección eficaces. UNICEF España Dirección de sensibilización y políticas de infancia*. Recuperado de: <https://www.observatoriodelainfancia.es/oia/esp/descargar.aspx?id=7872&tipo=documento>
- UNICEF España. (2015). Convención sobre los Derechos del Niño. Madrid: UNICEF Comité Español. Recuperado de: <https://www.unicef.es/publicacion/convencion-sobre-losderechos-del-nino>
- UNICEF. (2004). Sport, recreation and play. UNICEF <https://www.unicef.org/bolivia/informes/deporte-recreaci%C3%B3n-y-juego>

- UNICEF. (2019). *Getting into the Game Understanding: the evidence for child-focused sport for development*. Report Summary
- Vertommen, T., Kampen, J. K., Schipper-van Veldhoven, N., & Wouters, K. (2017). Interpersonal violence against children in sport in the Netherlands and Belgium. *Child Abuse & Neglect*, 51, 223-236.
- von Rosen, P., Frohm, A., Kottorp, A., Fridén, C., & Heijne, A. (2017). Multiple factors explain injury risk in adolescent elite athletes: Applying a biopsychosocial perspective. *Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports*, 27(12), 2059-2069. <https://doi.org/10.1111/sms.12855>
- Walter, N., Soenke, M., & Schmidt, U. (2022). Factors associated with disordered eating and eating disorder symptoms in adolescent elite athletes. *Sports Psychiatry*, 1(2), 47-56. <https://doi.org/10.1027/2197-652X/a000021>
- Weiss, M. R. (2011). Motivating kids in physical activity. *President's Council on Physical Fitness and Sports Research Digest*, 12(3), 1-8.
- Williams, C. D., & Martinez, L. M. (2021). Educational Programs in Sports Clubs: Enhancing Academic Success and Long-Term Development. Instituto de Investigación Educativa.

Anexos

Anexo 1. Obligaciones de las entidades deportivas LOPIVI.

Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y adolescencia frente la violencia, en adelante LOPIVI

CAPÍTULO IX: Del ámbito del deporte y el ocio

Artículo 47. Protocolos de actuación frente a la violencia en el ámbito deportivo y de ocio.

Las administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, regularán protocolos de actuación que recogerán las actuaciones para construir un entorno seguro en el ámbito deportivo y de ocio y que deben seguirse para la prevención, detección precoz e intervención, frente a las posibles situaciones de violencia sobre la infancia y la adolescencia comprendidas en el ámbito deportivo y de ocio. Dichos protocolos deberán ser aplicados en todos los centros que realicen actividades deportivas y de ocio, independientemente de su titularidad y, en todo caso, en la Red de Centros de Alto Rendimiento y Tecnificación Deportiva, Federaciones Deportivas y Escuelas municipales.

Artículo 48. Entidades que realizan actividades deportivas o de ocio con personas menores de edad de forma habitual.

1. Las entidades que realizan de forma habitual actividades deportivas o de ocio con personas menores de edad están obligadas a:

- a) Aplicar los protocolos de actuación a los que se refiere el artículo anterior que adopten las administraciones públicas en el ámbito deportivo y de ocio.
- b) Implantar un sistema de monitorización para asegurar el cumplimiento de los protocolos anteriores en relación con la protección de las personas menores de edad.

c) Designar la figura del Delegado o Delegada de protección al que las personas menores de edad puedan acudir para expresar sus inquietudes y quien se encargará de la difusión y el cumplimiento de los protocolos establecidos, así como de iniciar las comunicaciones pertinentes en los casos en los que se haya detectado una situación de violencia sobre la infancia o la adolescencia.

d) Adoptar las medidas necesarias para que la práctica del deporte, de la actividad física, de la cultura y del ocio no sea un escenario de discriminación por edad, raza, discapacidad, orientación sexual, identidad sexual o expresión de género, o cualquier otra circunstancia personal o social, trabajando con los propios niños, niñas y adolescentes, así como con sus familias y profesionales, en el rechazo al uso de insultos y expresiones degradantes y discriminatorias.

e) Fomentar la participación activa de los niños, niñas y adolescentes en todos los aspectos de su formación y desarrollo integral.

f) Fomentar y reforzar las relaciones y la comunicación entre las organizaciones deportivas y los progenitores o quienes ejerzan funciones de tutela, guarda o acogimiento.

2. Asimismo, además de la formación a la que se refiere el artículo 5, quienes trabajen en las citadas entidades deberán recibir formación específica para atender adecuadamente las diferentes aptitudes y capacidades de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad para el fomento y el desarrollo del deporte inclusivo de estos.

Anexo 2. Convención de los derechos del Niño



Anexo 3. Hoja de información y consentimiento Subcomité de Ética

TÍTULO DEL PROYECTO: Hacia un deporte sano, seguro, divertido e inclusivo para la infancia y la adolescencia: estudio piloto para validar un protocolo de autoevaluación por parte de los clubes.

INVESTIGADOR RESPONSABLE: Víctor J. Rubio Franco, Catedrático del Dpto. de Psicología Biológica y de la Salud (victor.rubio@uam.es)

INVESTIGADORES PARTICIPANTES:

Teresa González González, estudiante del Máster en Psicología de la Actividad Física y del Deporte en la UAM

Gema Martín, psicóloga del deporte del Centro de Psicología Aplicada al Deporte de la UAM

Roberto Ruiz Barquín, especialista en Psicología del Deporte y la Actividad Física, UAM.

HOJA DE INFORMACIÓN

Nos dirigimos a usted para informarle del siguiente estudio en el que le invitamos a participar. A continuación, viene la información relativa al mismo, para que pueda juzgar y determinar, en su caso, si quisiera colaborar en él. Si tiene cualquier cuestión, no dude en preguntarnos, directamente o a través de la dirección electrónica

teresa.gonzalezg@estudiante.uam.es

Con motivo de la realización del Trabajo de Fin de Máster de Teresa González González, estudiante del Máster en Psicología del Deporte y la Actividad Física de la Universidad Autónoma de Madrid, del que es tutor responsable el Prof. Víctor J. Rubio (victor.rubio@uam.es), del Dpto. de Psicología Biológica y de la Salud de esta Universidad, se está llevando a cabo una investigación llamada Hacia un deporte sano, seguro, divertido e inclusivo para la infancia y la adolescencia: estudio piloto para validar un protocolo de autoevaluación por parte de los clubes.

El objetivo principal es el diseño y aplicación de un instrumento fácilmente administrable para la detección temprana de posibles amenazas a la salud, la seguridad, la inclusión y el disfrute de niños, niñas y adolescentes (NNA) en el deporte organizado.

El acceso de la información se realizará mediante entrevista, observación y encuesta a diferentes personas adultas del club: directivos y entrenadores, principalmente. En función del puesto se os pedirá la colaboración mediante encuesta o entrevista sobre los aspectos de funcionamiento de club y/o de alguno/s de sus equipos. Usted siempre podrá suspender su colaboración en cualquier momento y sin que tenga que dar ningún motivo de ello.

PROCEDIMIENTO

El instrumento, elaborado por el grupo de investigación, tras la revisión de literatura y la evidencia científica, tratará de identificar riesgos asociados a la práctica deportiva y la promoción de un entorno seguro y saludable, tanto del club a nivel de organización como de cada uno de los equipos del mismo.

Para ello se necesita el cumplimiento del instrumento de diferentes personas adultas del club, junta directiva y entrenadores, que se llevará a cabo de forma auto-administrada o mediante encuesta. También se realizará una observación sistemática del club y sus instalaciones.

MUESTRA

El estudio utiliza el club como unidad de análisis. Este estudio piloto se llevará a cabo seleccionando a 3 de ellos por criterios circunstanciales (clubes que tienen convenios con el CPAd). Los clubes deciden quiénes son los informantes para cumplimentar el cuestionario, puede hacerlo una única persona o varias. Las instrucciones que vamos a proporcionar serán que el/los informantes puedan tener la información relevante para poder hacer una auditoría interna de las medidas de protección y seguridad desarrolladas dentro del club y que afectan a la infancia y adolescencia. En ese sentido, los informantes puede ser miembros de la junta directiva, directores deportivos o entrenadores. En todos los casos, serán los clubes quienes decidan quiénes y cuántos son los que cumplimentan dicha información. Ello va a estar también en función de características propias del club, como el tamaño (a mayor tamaño, es probable que el club decida contar con más de un informante debido a la dificultad de que una sola persona tenga toda la información) o el organigrama (un único director deportivo vs. coordinadores por categorías).

En todos los casos, la información que se recaba, como se señala en el proyecto, es sobre el club, no sobre los informantes o los participantes (e.g., II.A.4. El club monitoriza con periodicidad al menos anual el grado de integración, satisfacción y disfrute de los menores deportistas con el club, la actividad deportiva y los agentes implicados (p.e. realiza una encuesta anual de satisfacción entre todos los integrantes); IV.A.3 Se hace partícipes a las familias del proceso deportivo y formativo de sus hijos).

BENEFICIOS Y RIESGOS ASOCIADOS A SU PARTICIPACIÓN

La participación en este estudio supone beneficiarse de un informe general sobre el estado de club en cuanto a posibles riesgos y su gravedad para la infancia y adolescencia. Además, se estará contribuyendo a la mejora del instrumento que velará por el cumplimiento

de la LOPIVI y las aportaciones a la misma desde la psicología del deporte.

Por otro lado, no se espera que se derive de forma directa ningún tipo de riesgo por su participación

TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, toda la información que se obtenga será utilizada exclusivamente para la consecución de los objetivos del proyecto de investigación, garantizándose la más absoluta confidencialidad de los datos de los participantes en el estudio, que en ningún caso serán suministrados a ninguna persona diferente de los investigadores.

A lo largo del proyecto de investigación, puede realizar las preguntas que necesite, bien directamente al investigador o a través de correo electrónico a la siguiente dirección: teresa.gonzalezg@estudiante.uam.es (especificando en el asunto el título de este estudio).

Si está de acuerdo en participar, por favor, cumplimente y firme la siguiente página y conserve ésta por si desea ponerse en contacto en algún momento con los responsables del proyecto.

Gracias por su colaboración

Yo, D./Dña. _____, con
D.N.I./Pasaporte/Permiso de residencia nº _____ del club
deportivo _____, en condición de
directivo/entrenador/otros (señale lo que proceda) he sido adecuadamente informado/a de las
condiciones de participación en el Proyecto de Investigación *Hacia un deporte sano, seguro,
divertido e inclusivo para la infancia y la adolescencia: estudio piloto para validar un
protocolo de autoevaluación por parte de los clubes* del que es responsable el Prof. Víctor J.
Rubio, catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid.

Tengo claro su objetivo y acepto a participar del proceso de investigación proporcionando los
datos requeridos.

Por todo ello, doy mi consentimiento voluntariamente y sin ninguna contraprestación y entiendo
que puedo dejar de participar en cualquier momento sin ninguna desventaja.

Anexo 4. Leyenda de Condiciones y sus factores de riesgo asociados

1. Lesiones

- 1.1. Lesiones previas
- 1.2. Aptitud física (flexibilidad, fuerza, estabilidad, equilibrio, coordinación...)
- 1.3. Sueño (dormir <8 h entre semana; disminución del volumen de sueño)
- 1.4. Índice de nutrición (≤ 4)
- 1.5. Autoestima basada en competencias
- 1.6. Estrés (problemas diarios y acontecimientos negativos de la vida)
- 1.7. Mayor intensidad de entrenamiento
- 1.8. Mayor carga de entrenamiento
- 1.9. Aumento de días de competiciones
- 1.10. Equipo de protección
- 1.11. Superficie y clima

2. TCA

- 2.1. Relacionado con el género (feminidad, impulso por la musculatura, impulso por una forma corporal delgada)
- 2.2. Personalidad (perfeccionismo, control de impulsos)
- 2.3. Tipo de deporte (deportes de riesgo)
- 2.4. Presión social y deportiva
- 2.5. Número de métodos de control de peso

3. Burnout

- 3.1. Agotamiento emocional.
- 3.2. Falta de empatía y despersonalización con grupo de entrenamiento.
- 3.3. Falta de disfrute en entrenamientos y competición.
- 3.4. Sensación de estancamiento y no progresión incluso con incremento de esfuerzo.
- 3.5. Descenso de rendimiento y eficiencia.
- 3.6. Desorganización conductual.
- 3.7. Pérdida de control.
- 3.8. Dificultad para expresar emociones positivas.
- 3.9. Pérdida de entusiasmo y difusión de expectativas deportivas.
- 3.10. Desórdenes del sueño.

- 3.11 Tendencia a mayor probabilidad de enfermedad.
- 3.12. Satisfacer a otras personas o sentirse comprometidos/atrapado (cumplimiento de expectativas de los demás para agradar renunciando a sus prioridades o deseos al menos de forma parcial).
- 3.13. Falta de apoyos social percibido por el entrenador o grupo de entrenamiento
***No es exactamente igual a los contenidos en el bloque 5.
- 3.14. Estados emocionales negativos y sufrimiento psico-físico previo.

4. Consumo de sustancias

- 4.1. Falta de una sólida oposición moral a las trampas.
- 4.2. Identidad centrada casi exclusivamente en deporte (no identidad que va más allá del deporte).
- 4.3 Falta de autocontrol.
- 4.4. Falta de resiliencia ante presiones grupales
- 4.5 Ausencia de vínculos seguros afectivos en todas las etapas vitales del deportista

5. Violencia

- 5.1. Estilo autoritario y rígido
- 5.2. Críticas constantes, insultos y humillaciones
- 5.3. Comportamientos distintos de unos jugadores a otros. Favoritismo
- 5.4. Falta de comunicación entrenador-deportista. Falta de apoyo emocional
- 5.5. Presión por los resultados. Enfoque excesivo por ganar
- 5.6. Exclusión social
- 5.7. Presión excesiva de las familias
- 5.8. Desequilibrio académico-deportivo
- 5.9. Falta de apoyo y afecto por parte de la familia
- 5.10. Déficit de comunicación entre padres, entrenadores y deportistas

6. Salvaguarda

- 6.1. Canales comunicación
- 6.2. Clima normalizado violencia
- 6.3. Ausencia de Políticas

6.4. Falta de formación (6.8. Falta de formación de todos los actores del deporte)

6.5. Diversidad

6.6. Educación derechos deportistas

6.7. Falta de programas de bienestar y salud mental de los deportistas

Anexo 5. Relación entre ítems CHASSE-Organizacional, condición y factores de riesgo.

I.A	ENTORNOS FÍSICOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA MENORES: CONDICIONES GENERALES DEL CLUB	CONDICIÓN	FACTORES DE RIESGO
I.A1	El lugar en el que se lleva a cabo la actividad está libre de peligros que pueden atentar contra la seguridad física de los y las deportistas (p.e., muretes u otros impedimentos lindantes con los límites de la cancha, superficie de juego irregular o con obstáculos, mojada o resbaladiza, ...).	Lesiones (1)	Superficie y clima (1.11)
I.A2	Se cuenta con los medios materiales necesarios para hacer una atención de urgencia durante la práctica deportiva (p.e., botiquín de primeros auxilios regularmente abastecido; camilla, desfibrilador, ...).	Lesiones (1)	Equipos de protección (1.10)
I.A3	Los/las menores están supervisados por un adulto en todo momento mientras realizan la actividad deportiva (p.e. nunca están solos en el campo de juego, existe una ratio de monitores establecido por número de deportistas, no realizan actividades fuera de las instalaciones sin que un adulto los acompañe...).	Salvaguarda (6)	Falta de formación (6.4)
I.A4	El equipamiento y las protecciones se encuentran en condiciones adecuadas y se utilizan de manera regular mientras se realiza la actividad deportiva (p.e., se verifica que se lleva en buen estado, se utiliza el casco, las espinilleras, las rodilleras, ..., en aquellos deportes que así lo requieran).	Lesiones (1)	Equipos de protección (1.10)
I.A5	Se cuenta con un registro de lesiones y otras condiciones médicas de los jugadores del club que permita adaptar la actividad a las condiciones físicas concretas de cada deportista.	Lesiones (1)	Superficie y clima (1.11) índice de nutrición (1.4)
I.A6	Los lugares privados (duchas, aseos y/o vestuarios) están protegidos o supervisados para que no pueda pasar ningún adulto que no esté autorizado por el club.	Salvaguarda (6)	Ausencia de políticas (6.3)
I.A7	Se instruye a los y las menores deportistas en alimentación saludable y adecuada a la actividad deportiva y edad.	Lesiones (1) TCA (2)	índice de nutrición (1.4)
I.A8	Se instruye a los y las menores deportistas en pautas de sueño y descanso entre actividad deportiva.	Lesiones (1) Burnout (3)	Sueño (1.3) Desórdenes del sueño(3.10)
I.A9	Se instruye a los y las menores deportistas en los riesgos del consumo de sustancias dopantes, ergogénicas y psicoactivas.	Consumo sustancias nocivas (4)	Falta de una sólida oposición moral a las trampas. (4.1) Identidad centrada casi exclusivamente

			en deporte (no identidad que va más allá del deporte). (4.2) Falta de autocontrol (4.3) Falta de resiliencia ante presiones grupales (4.4) Ausencia de vínculos seguros afectivos en todas las etapas vitales del deportista (4.5)
II.A	ENTORNOS EMOCIONALES DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA MENORES: CONDICIONES GENERALES DEL CLUB	CONDICIÓN	FACTORES DE RIESGO
II.A1	El club tiene un programa de seguimiento de los técnicos deportivos para priorizar un entrenamiento orientado a la progresión integral del deportista sobre las acciones orientadas exclusivamente al resultado.	Lesiones (1) Violencia (5)	Autoestima basada en competencias (1.5) Estrés (1.6) Presión por los resultados (5.5)
II.A2	El club interviene cuando los padres o cualquier otro agente manifiesta un comportamiento incompatible con el <i>fairplay</i> y el desarrollo socioemocional de los y las menores. (p.e. llama a capítulo a aquéllos que hayan proferido insultos a los jueces o a los adversarios)	Lesiones (1) Violencia (5)	Autoestima basada en competencias (1.5) Estrés (1.6) Falta de comunicación entrenador-deportista (5.4) Presión de las familias (5.7) Déficit de comunicación entre padres-entrenadores y deportistas (5.10)
II.A3	El club supervisa con periodicidad el grado de integración, su satisfacción y el disfrute de los y las menores con el club, la actividad deportiva y los agentes implicados (p.e. realiza una encuesta anual de satisfacción entre todos los integrantes, ...)	Violencia (5) Salvaguarda (6)	Exclusión social (5.6) Falta de programas de bienestar y salud mental en los deportistas (6.7)
II.A4	El club se preocupa porque los y las menores tengan un equilibrio entre el deporte y su vida académica, (p.e muestra una preocupación por el rendimiento académico llevando un control de las notas de los deportistas o programando las actividades atendiendo al calendario escolar, ...)	Violencia (5)	Desequilibrio académico y deportivo (5.8)

II.A5	El club dispone de un protocolo de detección de problemas relacionados con la salud mental de sus deportistas (p.e. solicita regularmente a los entrenadores que identifiquen aquellos deportistas que presentan una exagerada respuesta emocional ante un pequeño conflicto, frustración o discusión con compañeros o entrenador, que tienen niveles bajos de autoestima y confianza, ...)	TCA (2) Burnout (3) Violencia (5) Salvaguarda (6)	TCA y Burnout no hay factores de riesgo asociados Presión excesiva de las familias (5.7) Falta de programas de bienestar y salud mental (6.7)
III.A	FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN: CONDICIONES GENERALES DEL CLUB	CONDICIÓN	FACTORES DE RIESGO
III.A1	El club cuenta con un delegado/a de protección a la infancia y la adolescencia designado de forma explícita y oficial	Salvaguarda (6)	Ausencia de políticas (6.3)
III.A2	El club cuenta con un plan de formación sobre protección y salvaguarda en menores que se imparte a todos los/as entrenadores del club (p.e., lleva a cabo acciones formativas dentro del club o incita y financia que los integrantes del club puedan participar en acciones formativas externas y se verifica la asistencia, ...)	Burnout (3) Salvaguarda (6)	Estados emocionales negativos y sufrimiento psico-físico previo (3.14) Ausencia de políticas (6.3) Falta de formación (6.4)
III.A3	El club cuenta con una directiva comprometida y sensibilizada hacia la protección y salvaguarda en menores (p.e., existe un plan de formación específico para los miembros de la junta directiva, los miembros de la junta directiva están involucrados interna o externamente en acciones y redes de salvaguarda...).	Burnout (3) Salvaguarda (6)	Agotamiento emocional. (3.1) Falta de empatía y despersonalización con grupo de entrenamiento. (3.2) Falta de disfrute en entrenamientos y competición. (3.3) Dificultad para expresar emociones positivas. (3.8) Pérdida de entusiasmo y difusión de expectativas deportivas. (3.9) Falta de apoyos social percibido por el entrenador o grupo de entrenamiento (3.13) Ausencia de políticas (6.3)

III.A4	El club cuenta con un plan de formación y sensibilización sobre protección y salvaguarda en menores dirigido a sus deportistas (p.e., realizan acciones formativas en las que se verifica la asistencia, ...).	Salvaguarda (6)	Falta de formación (6.4)
III.A5	El club cuenta con un plan de formación y sensibilización sobre protección y salvaguarda en menores dirigido a las familias (p.e., se organizan escuelas de padres, se remiten comunicaciones a los domicilios, se solicita un compromiso previo de la familia para incorporar al menor al club, ...).	Lesiones (1) Burnout (3) Salvaguarda (6)	Estrés (1.6) Agotamiento emocional. (3.1) Desorganización conductual (3.6) Desórdenes del sueño (3.10) Tendencia a mayor probabilidad de enfermedad (3.11) Estados emocionales negativos y sufrimiento psico-físico previo.(3.14) Educación en los derechos a los deportistas (6.6) Falta de formación (6.4)
III.A6	Existen canales de comunicación efectivos (accesibles y conocidos) para poner en conocimiento situaciones de maltrato, ya sea como receptor o como testigo (p.e. hay posibilidades de hacer una queja de forma confidencial, existe una persona de referencia a la que presentar esa situación particular, ...)	Salvaguarda (6)	Canales de comunicación (6.1)
III.A7	El club promueve distintas iniciativas públicas para promover comportamientos seguros y protectores hacia los menores. (p.e. premios de valores, campañas de <i>fair play</i> , acciones de tolerancia cero contra la violencia, ...)	Salvaguarda (6)	Falta de formación (6.4)
IV.A	PARTICIPACIÓN: CONDICIONES GENERALES DEL CLUB	CONDICIÓN	FACTORES DE RIESGO
IV.A1	El club es un entorno abierto a la inclusión y no discrimina por motivos de género, raza, orientación sexual u otras características diversas (p.e. tiene tanto equipos mixtos, masculinos y femeninos, cuenta con menores con diversidad funcional por discapacidades físicas o sensoriales, cuenta con menores con diversidad funcional por discapacidad intelectual, ...)	Salvaguarda (6)	Falta de diversidad (6.5)
IV.A2	Se implica a los y las menores en la toma de decisiones del club (p.e. existen canales de comunicación accesibles y conocidos que se utilizan para expresar sugerencias y mejoras, se encuestan determinadas decisiones, ...).	Salvaguarda (6)	Educación en los derechos de los deportistas (6.6)

IV.A3	Se hace partícipes a las familias del proceso deportivo y formativo de sus hijos/as (p.e., se hace una reunión al año con las familias, se encuestan determinadas decisiones, ...).	Violencia (5)	Falta de apoyo y afecto por parte de la familia (5.9) Déficit de comunicación entre padres-entrenadores y deportistas (5.10)
IV.A4	El club ha establecido redes de contacto con otras entidades para promover la cultura de la salvaguarda de los y las menores en el deporte (p.e. ha establecido sinergias con otros clubes deportivos de la localidad, ha contactado con otras organizaciones sociales centradas en la infancia y la adolescencia, está en comunicación con los centros educativos de la zona, ...)	Violencia (5) Salvaguarda (6)	Desequilibrio académico-deportivo (5.8) Falta de programas de bienestar y salud mental de los deportistas (6.7) Formación (6.4)

Anexo 6. Relación entre ítems CHASSE-Equipo, condición y factores de riesgo.

I.B	ENTORNOS FÍSICOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA LOS MENORES: CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL EQUIPO	CONDICIÓN	FACTORES DE RIESGO
I.B1	Se llevan a cabo acciones programadas regulares de calentamiento para el acondicionamiento físico de los y las menores antes de iniciar la actividad.	1.Lesiones 3.Burnoutt	1.2. Aptitud física 3.6. Desorganización conductual
I.B2	Se llevan a cabo acciones programadas regulares de acondicionamiento psicológico de los y las deportistas para prepararlos para la actividad.	1.Lesiones 5. Violencia	1.5. Autoestima basada en competencias 1.6. Estrés 5.5. Presión por los resultados
I.B3	Se realizan sistemáticamente acciones programadas de estiramientos y ejercicios de vuelta a la calma para reducir la activación física y psicológica cuando termina la actividad deportiva.	1. Lesiones	1.2. Aptitud física 1.6. Estrés
I.B4	Se entrena de manera específica la flexibilidad, la fuerza, el equilibrio, la estabilidad y la coordinación (p.e., se hacen ejercicios de torsiones, lanzamientos, giros, etc. para entrenar flexibilidad; se llevan a cabo ejercicios de cargas controladas con repetición para entrenar la fuerza,...).	1.Lesiones 3.Burnout	1.2. Aptitud física 3.1. Agotamiento emocional. 3.10 Desórdenes del sueño. 3.11 Tendencia a mayor probabilidad de enfermedad. 3.14. Estados emocionales negativos y sufrimiento psico-físico previo.
I.B5	La distribución e intensidad de las cargas de entrenamiento se hace acorde con la edad, el desarrollo físico y el nivel de entrenamiento de los y las menores deportistas (p.e. con descanso suficiente entre sesión y sesión, ...).	1.Lesiones 2.TCA 3.Burnout	1.7. Mayor intensidad de entrenamiento 1.8. Mayor carga de entrenamiento 1.9. Aumento de días de competiciones 2.3. Tipo de deporte (deportes de riesgo) 2.4. Presión social y deportiva 3.10 Desórdenes del sueño. 3.11 Tendencia a mayor probabilidad de enfermedad

I.B6	Se adecúa la práctica deportiva a las condiciones climatológicas (p.e., se hacen pausas para hidratación si mucho calor; se utiliza ropa térmica si mucho frío, ...).	6. Salvaguarda	6.4. Falta de formación
I.B7	Se lleva a cabo un seguimiento del peso de los y las deportistas (p.e., se realizan pesajes, controles de peso y/o de ingesta de forma regular entre los miembros del equipo; se hacen “comentarios” al respecto del peso, ...).	2. TCA	2.5. Número de métodos de control de peso
I.B8	Se detectan deportistas con claras muestras de fatiga ya desde las fases iniciales del entrenamiento o sin tener justificación o correspondencia con las cargas de entrenamiento.	3. Burnout	3.1. Agotamiento emocional. 3.3. Falta de disfrute en entrenamientos y competición. 3.5. Descenso de rendimiento y eficiencia. 3.6. Desorganización conductual. 3.9. Pérdida de entusiasmo y difusión de expectativas deportivas. 3.10 Desórdenes del sueño. 3.11 Tendencia a mayor probabilidad de enfermedad Estilo de liderazgo inadecuado 3.13. Falta de apoyos social percibido por el entrenador o grupo de entrenamiento
I.B9	Se detectan deportistas que consumen regularmente sustancias ergogénicas y/o facilitadoras del rendimiento deportivo	4. Consumo de sustancias nocivas	4.1. Falta de una sólida oposición moral a las trampas. 4.2. Identidad centrada casi exclusivamente en deporte (no identidad que va más allá del deporte). 4.3 Falta de autocontrol. 4.4. Falta de resiliencia ante presiones grupales 4.5 Ausencia de vínculos seguros afectivos en todas las etapas vitales

II.B	ENTORNOS EMOCIONALES DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA LOS MENORES: CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL EL EQUIPO	CONDICIÓN	FACTORES DE RIESGO
------	---	-----------	--------------------

II.B1	El/a entrenador/a se centra eminentemente en mejorar las destrezas deportivas de sus deportistas por encima de los resultados.	1. Lesiones 5. Violencia	1.5. Autoestima basada en competencias 1.6. Estrés 5.5. Presión por los resultados
II.B2	El/a entrenador/a promueve un clima positivo entre sus deportistas (p.e., evita utilizar el sarcasmo, chillar, insultar...).	1. Lesiones 3. Burnour 5. Violencia	1.5. Autoestima basada en competencias 1.6. Estrés 3.2. Falta de empatía y despersonalización con grupo de entrenamiento. 5.2. Críticas constantes, insultos y humillaciones
II.B3	El/a entrenador/a interviene de forma eficaz en los casos de conflicto dentro del equipo o cuando se está dando cualquier circunstancia de exclusión de algún miembro.	5. Violencia	5.6. Exclusión social
II.B4	Los/las deportistas muestran que pueden hablar abiertamente con su entrenador/a (p.e., le confían sus preocupaciones, se acercan a él o ella de forma espontánea, ...)	5. Violencia	5.4.Falta de comunicación entrenador-deportista.
II.B5	El/la entrenador/a fomenta que los/las deportistas se traten con respeto y se apoyen (p.ej., evita que se recriminen entre ellos los fallos, promueve que se animen durante los momentos que estén entrenando o compitiendo, que se saluden al llegar, ...).	5. Violencia	5.2.Críticas constantes, insultos y humillaciones 5.6. Exclusión social
II.B6	El/la entrenador/a corrige de forma constructiva a sus deportistas y sus mensajes son positivos. (p.e., proporciona instrucciones durante el partido que ayuden a mejorar, da ánimos constantes, ...).	5. Violencia	5.1.Estilo autoritario y rígido 5.2.Críticas constantes, insultos y humillaciones 5.4.Falta de comunicación entrenador-deportista.
II.B7	El/la entrenador/a muestra una conducta ecuánime y de trato igual hacia sus deportistas (p.e., nunca permite competir a algún deportista que haya estado ausente de los entrenamientos de la semana cuando la regla así lo exige, no limita de forma ostentosa la participación de ninguno, ...).	5. Violencia	5.3.Comportamientos distintos de unos jugadores a otros. Favoritismo 5.6. Exclusión social
II.B8	El /la entrenador/a interviene con las familias de las que observa durante entrenamientos y competiciones dar instrucciones técnicas y/o hacer comentarios negativos de la práctica deportiva de sus hijos/as, de sus compañeros/as o de rivales.	5. Violencia	5.7. Presión excesiva de las familias 5.9.Falta de apoyo y afecto por parte de la familia
II.B9	El/la entrenador/a identifica a aquellos/as deportistas que tienen problemas para alcanzar su rendimiento óptimo y desarrolla planes individualizados y/o refiere a los recursos de apoyo necesarios (p.e., se pone en contacto con los padres, deriva a otros profesionales del club, ...).	6. Salvaguarda	6.7.Falta de programas de bienestar y salud mental de los deportistas
II.B10	Se detectan casos de deportistas que muestran conductas evitativas hacia la actividad deportiva (p.e., no acuden o llegan tarde sistemáticamente a los entrenamientos de forma no justificada, solicitan ir varias veces al baño durante la sesión, se aíslan del resto de	3.Burnout	3.1. Agotamiento emocional. 3.2. Falta de empatía y despersonalización con grupo de entrenamiento.

	compañeros durante la actividad, ...).		3.3. Falta de disfrute en entrenamientos y competición. 3.4. Sensación de estancamiento y no progresión incluso con incremento de esfuerzo. 3.5. Descenso de rendimiento y eficiencia. 3.8. Dificultad para expresar emociones positivas. 3.9. Pérdida de entusiasmo y difusión de expectativas deportivas. 3.13. Falta de apoyos social percibido por el entrenador o grupo de entrenamiento 3.14. Estados emocionales negativos y sufrimiento psico-físico previo.
--	--	--	---

III.B	FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN: CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL EQUIPO	CONDICIÓN	FACTORES DE RIESGO
III.B1	El entrenador/a tiene título oficial, que le asegura una formación específica en el trabajo con menores.	6. Salvaguarda	6.4. Falta de formación
III.B2	El entrenador/a tiene en vigor el certificado de ausencia de delitos sexuales.	6. Salvaguarda	6.3. Ausencia de Políticas 6.4. Falta de formación
III.B3	El entrenador/a está formado en protección y salvaguarda a la infancia (p.e. ha acudido a las formaciones que el club organiza, ha realizado cursos de formación externa, ...).	6. Salvaguarda	6.3. Ausencia de Políticas
III.B4	El entrenador/a participa activamente en las iniciativas del club para promover comportamientos seguros y protectores en sus deportistas (p.e., lleva a cabo iniciativas de fomento de los valores en el equipo subrayando las acciones de <i>fair play</i> realizadas por alguno de los deportistas, transmite al club los nombres de los más destacados en las iniciativas del club o externas, ...).	3. Burnout 4. Consumo de sustancias 5. Violencia 6. Salvaguarda	3.4. Sensación de estancamiento y no progresión incluso con incremento de esfuerzo. 3.5. Descenso de rendimiento y eficiencia. 4.1. Falta de una sólida oposición moral a las trampas. 4.2. Identidad centrada casi exclusivamente en deporte (no identidad que va más allá del deporte).

			5.5.Presión por los resultados 6.3. Ausencia de Políticas 6.4. Falta de formación
--	--	--	---

IV.B	PARTICIPACIÓN: CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL EQUIPO	CONDICIÓN	FACTORES DE RIESGO
IV.B1	El/la entrenador/a escucha los intereses de los/las menores al respecto de la actividad deportiva (p.e., valora colocar al deportista en la posición del campo en la que se siente más cómodo, ...).	3.Burnout 5. Violencia	3.1. Agotamiento emocional. 3.2. Falta de empatía y despersonalización con grupo de entrenamiento. 3.3. Falta de disfrute en entrenamientos y competición. 3.4. Sensación de estancamiento y no progresión incluso con incremento de esfuerzo. 3.5. Descenso de rendimiento y eficiencia. 3.9. Pérdida de entusiasmo y difusión de expectativas deportivas. 3.12. Satisfacer a otras personas o sentirse comprometidos/atrapado (cumplimiento de expectativas de los demás para agradar renunciando a sus prioridades o deseos al menos de forma parcial). 5.4.Falta de comunicación entrenador-deportista
IV.B2	El/la entrenador/a pide opinión a los deportistas sobre actividades a realizar o el peso de algunos ejercicios (p.e., les deja elegir de vez en cuando el tipo de calentamiento a realizar, ...).	3.Burnout 5. Violencia	3.2. Falta de empatía y despersonalización con grupo de entrenamiento. 3.3. Falta de disfrute en entrenamientos y competición. 3.4. Sensación de estancamiento y no progresión incluso con incremento de

			esfuerzo. 3.5. Descenso de rendimiento y eficiencia. 3.9. Pérdida de entusiasmo y difusión de expectativas deportivas. 3.12. Satisfacer a otras personas o sentirse comprometidos/atrapado 5.4.Falta de comunicación entrenador-deportista
IV.B3	El/la entrenador/a tiene reuniones, formales e informales, con las familias de los deportistas que dirige.	5. Violencia	5.7. Presión excesiva de las familias
IV.B4	Se detectan deportistas que no están disfrutando del deporte (p.e. muestran desgana o insatisfacción de forma constante en la realización de los ejercicios de entrenamiento, omiten su participación en actividades...).	3.Burnout	3.1. Agotamiento emocional. 3.2. Falta de empatía y despersonalización con grupo de entrenamiento. 3.3. Falta de disfrute en entrenamientos y competición. 3.4. Sensación de estancamiento y no progresión incluso con incremento de esfuerzo. 3.5. Descenso de rendimiento y eficiencia. 3.8. Dificultad para expresar emociones positivas. 3.9. Pérdida de entusiasmo y difusión de expectativas deportivas. 3.14. Estados emocionales negativos y sufrimiento psico-físico previo.

Anexo 7. Instrucciones generales CHASSE

La Ley Orgánica 8/2021, de Protección a la Infancia y a la Adolescencia frente a la Violencia (LOPVI), pretende promover los derechos de los niños, niñas y adolescentes consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño. Esos derechos aplican en muy diversos ámbitos, siendo el deporte uno de ellos. Para su fomento, es esencial asegurar y promover el respeto de la dignidad humana e integridad física y psicológica de los chicos y chicas que practican deporte de forma organizada e impulsar un deporte que sea sano, seguro, divertido e inclusivo.

La protección y salvaguarda de la infancia y la adolescencia en el deporte es objetivo de todos y, muy particularmente, de los responsables de las entidades en las que la actividad deportiva de los niños, niñas y jóvenes se lleva a cabo. El **CHASSE** (*Autoevaluación de Riesgos hacia la Salvaguarda y Protección de Menores en Entidades Deportivas*) es un instrumento diseñado para que el club pueda realizar un autodiagnóstico de su situación en cuanto a la protección de menores en el deporte. El instrumento permite el autodiagnóstico tanto a nivel de organización como a nivel de equipos específicos dentro del club.

El instrumento está diseñado para que se puede autoadministrar. Para proceder al autodiagnóstico, se sugiere que se identifique/n a la/s persona/s que pueden dar información precisa y fiable de cada uno de los bloques de los que consta el instrumento. El número y características de los informantes depende exclusivamente de la accesibilidad a la información que cada uno pueda tener.

Ejemplos de posibles informantes que pueden cumplimentar, total o parcialmente, los distintos bloques pueden el/a secretario/a técnico/a, el/a director/a deportivo/a, el/a coordinador/a de sección, el/a responsable de categorías... Estos informantes pueden proceder cumplimentando directamente la información a partir del conocimiento que posean, pueden realizar observaciones para explorar aspectos específicos o pueden entrevistarse con otros agentes del club (entrenadores y otro staff técnico, deportistas, padres...).

Recuerde que éste es un instrumento que tiene que ser útil para la prevención de aquellos aspectos que pueden atentar contra la salud, la seguridad, el disfrute y la inclusión de los menores que realizan actividad física en su club, y para que el club pueda proceder, en su caso, a realizar las adaptaciones pertinentes que incrementen su salvaguarda y protección.¹

La información que se obtenga es para uso interno del club, en el afán por fomentar una cultura de la protección y salvaguarda de los y las menores en el deporte. En ese sentido, evite, utilizar como informante a agentes que son directamente evaluados (e.g., los/as entrenadores/as de los equipos que se evalúan) que pudieran sesgar la información recogida.

Este instrumento también permite el análisis del grado de confluencia en la visión sobre la salvaguarda que el club tiene a nivel organizacional entre diferentes responsables y agentes. En ese sentido, utilizar a diferentes informantes que analizan los mismos bloques permite contrastar el grado de acuerdo tanto en la visión de los aspectos organizacionales de la salvaguarda como en cuanto a los criterios que se aplican para juzgarlos.

Si desea llevar a cabo la evaluación en un formato electrónico, puede realizarla en este enlace:

CHASSE -Nivel Organizacional: https://psyuam.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_b3CvvuDfiTVTQvs

CHASSE -Nivel Equipo: https://psyuam.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_9t0glbgOnkWjovY

Anexo 8. Instrucciones específicas CHASSE-Organizacional

Usted ha sido escogido por su entidad para actuar como informante en la cumplimentación del **CHASSE** (*Autoevaluación de Riesgos hacia la Salvaguarda y Protección de Menores En Entidades Deportivas*)-**Nivel Organizacional**. El instrumento sirve de base para que el club pueda realizar un autodiagnóstico de su situación en cuanto a la protección de menores en el deporte.

De acuerdo con la Ley Orgánica 8/2021, de Protección a la Infancia y a la Adolescencia frente a la Violencia (LOPVI), el instrumento se organiza en cuatro bloques para su diagnóstico:

- Bloque I: Entornos físicos de seguridad y protección en menores.
- Bloque II: Entornos emocionales de seguridad y protección en menores.
- Bloque III: Formación y sensibilización.
- Bloque IV: Participación.

En cada bloque se presentan circunstancias que pueden afectar a la salvaguarda de los menores a nivel de organización. Para su cumplimentación, recurra a su conocimiento sobre los aspectos evaluados, a la observación para determinar si las circunstancias que aparecen en éste se verifican en su club y/o a la entrevista de agentes (otros miembros del staff, entrenadores, deportistas, padres...) que le puedan facilitar la información.

Recuerde que éste es un instrumento que tiene que ser útil para la prevención de aquellos aspectos que pueden atentar contra la salud, la seguridad, el disfrute y la inclusión de los menores que realizan actividad física en su club, y para que el club pueda proceder, en su caso, a realizar las adaptaciones pertinentes que incrementen su salvaguarda y protección.³ En ese sentido, la información debe ser todo lo precisa y detallada posible como para poder realizar, en su caso las modificaciones oportunas.

La forma de cumplimentación simplemente requiere marcar la opción que corresponda al respecto de si las circunstancias que aparecen se verifican en su club. Deberá:

- Marcar **SÍ**, cuando conoce/ ha observado/se le ha reportado que se cumple la circunstancia.
- Marcar **NO** cuando conoce/ ha observado/se le ha reportado que no se cumple la circunstancia.
- Marcar **PARCIALMENTE** cuando conoce/ ha observado/se le ha reportado que se cumple sólo parcialmente y especificar los aspectos que no se cumplen.
- Marcar **N/D** si la circunstancia no aplica al club o el informante no dispone de esa información.

A continuación, se le presenta un ejemplo para cada una de las respuestas posibles en un caso hipotético de un club:

³ Si tiene cualquier duda sobre la aplicación, puede contactar directamente con el responsable del club

NOMBRE DEL CLUB	<i>Cumpliméntese aquí el nombre del</i>			
INFORMA	<i>Cumpliméntese aquí el nombre la persona</i>			
PUESTO/ROL			FECHA	
<i>Cumpliméntese aquí el cargo que desempeña en el club (p.e., directora</i>		<i>Cumpliméntese aquí la fecha</i>		

CONDICIONES GENERALES DEL CLUB	SÍ	NO	PARCIALMENTE (Especificar los aspectos que NO se cumplen)	N/D
El club interviene cuando los padres o cualquier otro agente manifiesta un comportamiento incompatible con el <i>fairplay</i> y el desarrollo socioemocional de los y las menores.	X			
El club ha establecido redes de contacto con otras entidades para promover la cultura de la salvaguarda de los y las menores en el deporte (p.e. ha establecido sinergias con otros clubes deportivos de la localidad, ha contactado con otras organizaciones sociales centradas en la infancia y la adolescencia, está en comunicación con los centros educativos de la zona, ...)		X		
El lugar en el que se lleva a cabo la actividad está libre de peligros que pueden atentar contra la seguridad física de los deportistas (p.e., muretes u otros impedimentos lindantes con los límites de la cancha, superficie de juego irregular o con obstáculos, mojada o resbaladiza, ...).			X <i>La cancha tiene algunas tablillas del parquet levantadas.</i>	
Los lugares privados (duchas, aseos y/o vestuarios) están protegidos o supervisados para que no pueda pasar ningún adulto que no esté autorizado por el club.				X <i>La gestión no depende propiamente del club y se desconoce</i>

Al final de cada bloque existe un apartado abierto de observaciones por si se estima oportuno añadir alguna otra información relevante. Asimismo, se cerrará con una pregunta sobre la valoración global que el informante realice acerca de la salvaguarda y protección en el club.

Anexo 9. Instrucciones específicas CHASSE-Equipo

INSTRUCCIONES

Usted ha sido escogido por su entidad para actuar como informante en la cumplimentación del **CHASSE** (*Autoevaluación de Riesgos hacia la Salvaguarda y Protección de Menores En Entidades Deportivas*)-**Nivel Equipo**. El instrumento sirve de base para que el club pueda realizar un autodiagnóstico de la situación en cuanto a la protección de menores en el deporte en relación específicamente con el equipo evaluado.

De acuerdo con la Ley Orgánica 8/2021, de Protección a la Infancia y a la Adolescencia frente a la Violencia (LOPVI), el instrumento se organiza en cuatro bloques para su diagnóstico:

- Bloque I: Entornos físicos de seguridad y protección en menores.
- Bloque II: Entornos emocionales de seguridad y protección en menores.
- Bloque III: Formación y sensibilización.
- Bloque IV: Participación.

En cada bloque se presentan circunstancias que pueden afectar a la salvaguarda de los menores en el equipo evaluado. Para su cumplimentación, recurra a su conocimiento sobre los aspectos evaluados, a la observación para determinar si las circunstancias que aparecen en éste se verifican en su club y/o a la entrevista de agentes (otros miembros del staff, entrenadores, deportistas, padres...) que le puedan facilitar la información.

Recuerde que éste es un instrumento que tiene que ser útil para la prevención de aquellos aspectos que pueden atentar contra la salud, la seguridad, el disfrute y la inclusión de los menores que realizan actividad física en el equipo, y para que el club pueda proceder, en su caso, a realizar las adaptaciones pertinentes que incrementen su salvaguarda y protección.⁴ En ese sentido, la información debe ser todo lo precisa y detallada posible como para poder realizar, en su caso las modificaciones oportunas.

La forma de cumplimentación simplemente requiere marcar la opción que corresponda al respecto de si las circunstancias que aparecen se verifican en el equipo que está evaluando. Deberá:

- Marcar **SÍ**, cuando conoce/ ha observado/se le ha reportado que se cumple la circunstancia.
- Marcar **NO** cuando conoce/ ha observado/se le ha reportado que no se cumple la circunstancia.
- Marcar **PARCIALMENTE** cuando conoce/ ha observado/se le ha reportado que se cumple sólo parcialmente y especificar los aspectos que no se cumplen.
- Marcar **N/D** si la circunstancia no aplica al club o el informante no dispone de esa información.

A continuación, se le presenta un ejemplo para cada una de las respuestas posibles en un caso hipotético de un equipo:

⁴ Si tiene cualquier duda sobre la aplicación, puede contactar directamente con el responsable del club

NOMBRE DEL CLUB	Cumpliméntese aquí el nombre del club			Cumpliméntese aquí el nombre del equipo
EQUIPO				
INFORMA	Cumpliméntese aquí el nombre la persona			
PUESTO/ROL	Cumpliméntese aquí el cargo que desempeña en el club (p.e., directora deportiva; coordinador de sección...)			FECHA
				Cumpliméntese aquí la fecha

CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL EQUIPO	SÍ	NO	PARCIALMENTE (Especificar los aspectos que NO se cumplen)	N/D
------------------------------------	----	----	--	-----

Se llevan a cabo acciones programadas regulares de calentamiento para el acondicionamiento físico de los/las menores antes de iniciar la actividad	X			
--	---	--	--	--

Se entrena de manera específica la flexibilidad, la fuerza, el equilibrio, la estabilidad y la coordinación (p.e., se hacen ejercicios de torsiones, lanzamientos, giros, etc. para entrenar flexibilidad; se llevan a cabo ejercicios de cargas controladas con repetición para entrenar la fuerza,...).		X		
---	--	---	--	--

CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL EQUIPO	SÍ	NO	PARCIALMENTE (Especificar los aspectos que NO se cumplen)	N/D
------------------------------------	----	----	--	-----

El entrenador/a interviene con las familias de las que observa durante entrenamientos y competiciones que dan instrucciones técnicas y/o hacen comentarios negativos de la práctica deportiva de sus hijos/as, de sus compañeros/as o de los rivales.			X Lo hace únicamente con algunas familias con las que parece tener mayor confianza	
---	--	--	---	--

El entrenador/a tiene título oficial, que le asegura una formación específica en el trabajo con menores.				X No se solicita y se desconoce
--	--	--	--	------------------------------------

Al final de cada bloque existe un apartado abierto de observaciones por si se considera que hay que añadir o comentar alguna otra información relevante. Asimismo, se cerrará con una pregunta sobre la valoración global que el informante realice acerca de la salvaguarda y protección en el equipo de el que se está realizando el autodiagnóstico.